MỤC LỤC

1. QUY TRÌNH TRUYỀN DỊCH TĨNH MẠCH THƯỜNG QUY.....2
2. QUY TRÌNH TIÊM BẮP.....6
3. QUY TRÌNH KỸ THUẬT TIÊM DƯỚI DA.....9
4. QUY TRÌNH TIÊM TRONG DA.....11
5. QUY TRÌNH TIÊM TĨNH MẠCH, TRUYỀN TĨNH MẠCH.....13
6. QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGHIỆM PHÁP DÂY THẮT.....16
7. QUY TRÌNH KỸ THUẬT LẤY ĐỜM BẰNG TÁC ĐỘNG VỖ RUNG.....18
8. QUY TRÌNH TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH NGỘ ĐỘC.....21
9. QUY TRÌNH LẤY DỊCH TỴ HẦU ĐỂ XÉT NGHIỆM.....24
10. QUY TRÌNH ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN.....26
11. QUY TRÌNH CHĂM SÓC CATHETER TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN.....29
12. QUY TRÌNH CHĂM SÓC CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM.....31
13. QUY TRÌNH ĐẶT ỐNG THÔNG DẠ DÀY.....34
14. QUY TRÌNH NUÔI DƯỠNG QUA ỐNG THÔNG DẠ DÀY.....37
15. QUY TRÌNH ĐẶT ỐNG THÔNG DẪN LƯU BÀNG QUANG.....41
16. QUY TRÌNH ĐẶT ỐNG THÔNG TIỂU 1 LẦN.....44
17. QUY TRÌNH KHÍ DUNG THUỐC GIÃN PHẾ QUẢN.....47
18. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH.....49
19. QUY TRÌNH GIẢM ĐAU BẰNG MORPHIN TĨNH MẠCH THEO KIỂU PCA.....52

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN DÙNG CHUNG

CHƯƠNG I

Bản hoàn thiện trình thẩm định chuyên môn
Ngày cập nhật 13/10/2026
Mã tài liệu và phiên bản: .....
Số quyết định ban hành và ngày áp dụng: .....

2

Phạm vi và nguyên tắc áp dụng

Tài liệu gồm 19 quy trình từ bản nguồn, trình bày theo đề cương của Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023. Quyết định này là căn cứ cấu trúc và định dạng, không thay thế hướng dẫn chuyên môn của từng kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng thuốc hoặc thiết bị.

Nhân viên thực hiện phải được đào tạo, có năng lực, được phân công và làm việc trong phạm vi hành nghề. Thuốc, liều, đường dùng, tốc độ và thông số thiết bị thực hiện theo chỉ định và phác đồ của bệnh viện; các nội dung cho trẻ em cần hướng dẫn chuyên biệt phù hợp tuổi và cân nặng.

Danh sách hội đồng thẩm định và ban biên soạn

Chủ tịch: ..... Thành viên: .....
Người biên soạn: ..... Người kiểm tra: .....
Thông tin phê duyệt được bổ sung theo quyết định của bệnh viện.

Danh mục chữ viết tắt

QTKT: Quy trình kỹ thuật; TM: Tĩnh mạch; COPD: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; SpO_2: Độ bão hòa oxy ngoại vi; PCA: Giảm đau do người bệnh tự kiểm soát; PVP: Povidone-iodine; Fr: French, đơn vị cỡ ống; mL: Mililít.

Mục lục quy trình

1. QUY TRÌNH TRUYỀN DỊCH TĨNH MẠCH THƯỜNG QUY.....4
2. QUY TRÌNH TIÊM BẮP.....Error: Reference source not found
3. QUY TRÌNH KỸ THUẬT TIÊM DƯỚI DA.....12
4. QUY TRÌNH TIÊM TRONG DA.....16
5. QUY TRÌNH TIÊM TĨNH MẠCH, TRUYỀN TĨNH MẠCH.....20
6. QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGHIỆM PHÁP DÂY THẮT.....24
7. QUY TRÌNH KỸ THUẬT LẤY ĐỜM BẰNG TÁC ĐỘNG VỖ RUNG.....27
8. QUY TRÌNH TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH NGỘ ĐỘC.....30
9. QUY TRÌNH LẤY DỊCH TỴ HẦU ĐỂ XÉT NGHIỆM.....34
10. QUY TRÌNH ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN.....38
11. QUY TRÌNH CHĂM SÓC CATHETER TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN.....42
12. QUY TRÌNH CHĂM SÓC CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM.....45
13. QUY TRÌNH ĐẶT ỐNG THÔNG DẠ DÀY.....49
14. QUY TRÌNH NUÔI DƯỠNG QUA ỐNG THÔNG DẠ DÀY.....53
15. QUY TRÌNH ĐẶT ỐNG THÔNG DẪN LƯU BÀNG QUANG.....58
16. QUY TRÌNH ĐẶT ỐNG THÔNG TIỂU 1 LẦN.....63
17. QUY TRÌNH KHÍ DUNG THUỐC GIÃN PHẾ QUẢN.....67
18. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH.....70
19. QUY TRÌNH GIẢM ĐAU BẰNG MORPHIN TĨNH MẠCH THEO KIỂU PCA.....75

4

1. QUY TRÌNH TRUYỀN DỊCH TĨNH MẠCH THƯỜNG QUY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Khái niệm: truyền dịch là đưa một lượng thuốc, dịch truyền, các dung dịch cao phân tử hoặc một số dung dịch nuôi dưỡng...vào cơ thể người bệnh qua đường tĩnh mạch.

- Mục đích:

+ Hồi phục nhanh khối lượng tuần hoàn đã mất.

+ Nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch.

+ Đưa thuốc hoặc hóa chất vào để điều trị

+ Giải độc, lợi tiểu.

- Nguyên tắc chung:

+ Thực hiện theo đúng các bước kỹ thuật.

+ Đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn: rửa tay, kim tiêm, dây truyền chỉ dùng một lần.

+ Thực hiện 5 đúng.

+ Phát hiện tai biến và xử trí đúng khi truyền dịch.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh bị giảm khối lượng tuần hoàn do: sốc, tiêu chảy, bỏng, mất máu cấp...

- Các tình trạng bệnh nặng, chấn thương.

- Người bệnh bị mất máu.

- Người bệnh không ăn được do: hôn mê, tổn thương thực quản, đường tiêu hóa...

- Người bệnh ngộ độc.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Phù phổi cấp.

- Suy tim nặng.

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh mẫn cảm dị ứng với thành phần của dịch truyền.

- Tốc độ liều lượng theo chỉ định của bác sĩ tránh xảy ra tai biến đáng tiếc nhất là đối với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện: điều dưỡng 1 người.

5.2. Thuốc

- Dịch truyền theo chỉ định của bác sĩ.

- Hộp chống sốc theo quy định.

5

5.3. Vật tư

- Bộ dây truyền, kim truyền cho phù hợp.

- Găng tay sạch, dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

- Dây garo.

- Gạc, băng keo.

- Hộp đựng bông cồn 70%.

5.4. Trang thiết bị

- Mâm tiêm thuốc.

- Pen, ống cắm pen.

- Máy truyền dịch (nếu cần).

- Trụ treo dịch truyền.

- Máy đo huyết áp, đồng hồ bấm giây, nhiệt kế, ống nghe.

- Dụng cụ khác: hộp đựng vật sắc nhọn, thùng đựng rác thải theo quy định và xe tiêm.

5.5. Người bệnh

Chuẩn bị người bệnh

- Thông báo, giải thích cho người bệnh và gia đình về công việc mình sắp làm.

- Hướng dẫn cho người bệnh đi vệ sinh.

- Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Phiếu chăm sóc.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: chuẩn bị và thiết lập đường truyền khoảng 0,08–0,17 giờ; thời gian truyền theo loại dịch, thể tích và tốc độ do bác sĩ chỉ định.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Thực hiện 5 đúng.

- Cho người bệnh nằm ngửa thoải mái.

- Xác nhận đúng người bệnh bằng ít nhất hai thông tin nhận diện, đúng chỉ định và vị trí; kiểm tra dị ứng và nguy cơ liên quan. Thực hiện bảng kiểm an toàn phù hợp, giải thích và đặt tư thế trước kỹ thuật.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: thực hiện 5 đúng (đúng người bệnh, đúng thuốc, đúng liều, đúng đường dùng, đúng thời gian) giải thích cho người bệnh việc sắp làm, hướng dẫn người bệnh đi tiểu trước, cho người bệnh nghỉ ngơi lấy dấu hiệu sinh tồn.

- Bước 2: kiểm tra chất lượng dịch: màu sắc, hạn sử dụng...

6

- Bước 3: sát khuẩn nắp chai dịch.

- Bước 4: rửa tay thường quy.

- Bước 5: cắm dây truyền vào chai dịch, khóa dây truyền lại, treo chai dịch lên cọc truyền đuổi khí, khóa dây lại và đặt vào khay hạt đậu vô khuẩn.

- Bước 6: vận hành máy truyền dịch (nếu có), chỉnh tốc độ theo chỉ định.

- Bước 7: bộc lộ vùng tiêm truyền. xác định vị trí truyền.

- Bước 8: buộc dây garo.

- Bước 9: sát khuẩn vị trí truyền 2 lần, để khô da.

- Bước 10: điều dưỡng sát khuẩn tay nhanh và đi găng.

- Bước 11: luồn kim vào lòng tĩnh mạch. Tay trái dùng ngón một đè vào tĩnh mạch và kéo căng da tĩnh mạch ra. Tay phải đâm kim chếch 15–30° ngay trên tĩnh mạch mặt vát ngửa lên trên thấy máu trào ra đốc kim hạ thấp kim tiêm luồn vào tĩnh mạch.

- Bước 12: tháo dây garo

- Bước 13: nối dây truyền với kim luồn, mở khóa truyền. Kiểm tra máy truyền dịch(nếu có), vận hành chính xác theo chỉ định.

- Bước 14: cố định kim truyền, dây truyền bằng băng keo, đặt nẹp cố định cổ, cánh tay, chân (nếu cần thiết). Che kim ở vị trí truyền bằng miếng gạc nhỏ và cố định bằng băng keo. Điều chỉnh dịch truyền theo chỉ định

- Bước 15: giúp người bệnh ở tư thế thoải mái.

- Bước 16: dặn người bệnh, gia đình những điều cần thiết: khó thở, sắc mặt, tri giác.

- Bước 17: thu dọn dụng cụ, phân loại rác, rửa tay.

- Bước 18: ghi hồ sơ bệnh án và phiếu truyền dịch.

Kết thúc quy trình

- Đánh giá lại tình trạng người bệnh và kết quả kỹ thuật; bảo đảm tư thế an toàn, thu gom dụng cụ và vệ sinh tay.

- Ghi thời gian, nội dung thực hiện, thuốc/dịch và thông số thực tế nếu có, đáp ứng và bất thường; bàn giao người bệnh và kế hoạch theo dõi cho nhân viên hoặc bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi làm thủ thuật

- Quan sát sắc mặt người bệnh.

- Theo dõi tổng trạng.

7.2. Sau khi làm thủ thuật

- Theo dõi tổng trạng.

- Theo dõi dịch truyền, tốc độ.

7

- Theo dõi vị trí truyền dịch.

7.3. Vỡ mạch

- Nguyên nhân: thành mạch yếu, vị trí truyền bị đâm kim nhiều lần.

- Xử trí: rút kim ra và tìm vị trí khác để tiêm.

7.4. Tắc mạch

- Nguyên nhân: quá trình đuổi khí không tốt vẫn còn khí trong dây truyền.

- Đề phòng: đuổi hết khí trước khi truyền dịch cho người bệnh.

7.5. Sốc

- Nguyên nhân: có thể do dị ứng thành phần dịch, thuốc, truyền dịch quá nhanh…

- Triệu chứng: bồn chồn, hốt hoảng, mẩn ngứa, ban đỏ, nổi mề đay. Mạch nhanh nhỏ, khó bắt khó thở, kích thích, li bì hoặc hôn mê.

- Xử trí: khóa ngay dịch truyền. Xử trí theo phác đồ sốc phản vệ.

7.6. Phù phổi cấp

- Nguyên nhân: truyền nhanh một lượng dịch vào cơ thể. Xảy ra nhiều hơn đối với những người bệnh bị tim mạch.

- Triệu chứng: đau ngực dữ dội (ở trẻ lớn), khó thở, sùi bọt hồng, sắc mặt tím tái, hốt hoảng, kích thích. Nghe phổi thấy có rất nhiều ran ẩm. Mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt.

- Xử trí: ngừng truyền dịch. Cấp cứu hô hấp: mở thông đường thở, thở oxy, đặt nội khí quản, thở máy…Chuẩn bị các phương tiện, thuốc để cấp cứu cùng bác sĩ.

7.7. Nhiễm khuẩn

- Nguyên nhân: do không đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn, lưu kim lâu.

- Hậu quả: nhiễm trùng máu, nhiễm trùng nơi tiêm.

7.8. Phơi nhiễm nhân viên y tế

- Nguyên nhân: tổn thương do kim hoặc vật sắc nhọn đã sử dụng, tiếp xúc máu/dịch cơ thể qua niêm mạc hoặc da tổn thương. Không chụp lại nắp kim sau sử dụng; xử trí và báo cáo phơi nhiễm theo quy trình của bệnh viện.

- Đề phòng: đảm bảo tuyệt đối vô khuẩn, tiêm an toàn và thực hiện đầy đủ quy trình kỹ thuật truyền dịch tĩnh mạch.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế (2023), Quyết định số 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (căn cứ cấu trúc và định dạng).

2. Trần Thị Thuận (2007), Điều dưỡng cơ bản II, trang 330 - 336.

Phụ lục

Danh mục chuẩn bị để thực hiện quy trình truyền dịch thường qui

8

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		
2.1	Dịch truyền, thuốc truyền theo chỉ định của bác sĩ	Chai	Theo chỉ định
2.2	Hộp chống sốc	Hộp	01
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Bộ dây truyền dịch	Bộ	01
3.2	Kim truyền kích cỡ phù hợp	Cái	01
3.3	Găng tay sạch	Đôi	01
3.4	Cồn 70%	Chai	01
3.5	băng keo	Cuộn	01
3.6	Gạc che kim	Miếng	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Pen, ống cắm pen, trụ treo dịch truyền	Cái	01
4.2	Máy đo huyết áp, đồng hồ bấm giây, nhiệt kế, ống nghe, bút	Cái	01
4.3	Mâm tiêm thuốc, hộp đựng vật sắc nhọn, thùng đựng rác, xe tiêm thuốc	Cái	01

9

2. QUY TRÌNH TIÊM BẮP

1. ĐẠI CƯƠNG

Tiêm bắp là tiêm một lượng thuốc vào trong bắp thịt (trong cơ), giúp thuốc hấp thu vào cơ thể nhanh hơn tiêm dưới da.

2. CHỈ ĐỊNH

- Thuốc có dạng bào chế cho phép dùng đường tiêm bắp, theo chỉ định của bác sĩ và hướng dẫn sử dụng của từng thuốc. Không suy rộng đường dùng từ tiêm dưới da sang tiêm bắp.

- Lựa chọn đường tiêm bắp dựa trên đặc tính thuốc, mục đích điều trị và tình trạng người bệnh; không tiêm bắp chế phẩm không được phép dùng đường này.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Những thuốc gây hoại tử tổ chức: Canxi Clorua, đường ưu trương.

4. THẬN TRỌNG

Người bệnh dị ứng với các thành phần của thuốc.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện: điều dưỡng 1 người.

5.2. Thuốc

- Theo chỉ định của bác sĩ, hộp chống sốc, nước cất 5 mL, dung dịch sát trùng cồn 70%.

- Dung dịch sát trùng tay nhanh

5.3. Vật tư

- Găng tay, băng keo.

- Bơm tiêm 5 mL, kim rút thuốc 18, bông, gạc miếng, hộp đựng bông cồn.

5.4. Trang thiết bị

- Mâm tiêm thuốc.

- Pen và ống cắm pen.

- Hộp đựng vật sắc nhọn, thùng đựng rác thải theo quy định.

5.5. Người bệnh

- Nhận định tình trạng người bệnh, hỏi về tiền sử liên quan đến kỹ thuật.

- Giải thích về kỹ thuật sắp làm, gia đình người bệnh cam kết đồng ý kỹ thuật.. Hướng dẫn những điều cần thiết (nếu cần).

5.6. Hồ sơ bệnh án

Phiếu chăm sóc, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật.

10

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: dự kiến 0,08–0,17 giờ.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng bệnh

5.9. Kiểm tra hồ sơ

Kiểm tra người bệnh. Thực hiện 5 đúng. Người bệnh có thể nằm hoặc ngồi tùy vào vị trí vùng tiêm.

- Xác nhận đúng người bệnh bằng ít nhất hai thông tin nhận diện, đúng chỉ định và vị trí; kiểm tra dị ứng và nguy cơ liên quan. Thực hiện bảng kiểm an toàn phù hợp, giải thích và đặt tư thế trước kỹ thuật.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: điều dưỡng rửa tay thường quy.

- Bước 2: thực hiện 5 đúng.

- Bước 3: pha và lấy thuốc đúng kỹ thuật.

- Bước 4: kiểm tra thuốc trước khi bỏ vỏ thuốc.

- Bước 5: xác định đúng vị trí tiêm, sát khuẩn vị trí tiêm.

- Bước 6: sát khuẩn tay nhanh mang găng tay (nếu cần thiết).

- Bước 7: lựa chọn vị trí và chiều dài kim phù hợp tuổi, thể trạng, lượng thuốc và hướng dẫn của chế phẩm; đâm kim vuông góc 90° vào cơ, bơm thuốc theo tốc độ quy định. Không tiêm vào vùng viêm, tổn thương hoặc có nguy cơ tổn thương thần kinh. Quy định hút kiểm tra áp dụng theo từng thuốc; không hút kiểm tra khi tiêm vắc xin.

- Bước 8: rút kim, giúp người bệnh trở về tư thế thoải mái và hướng dẫn những điều cần thiết.

- Bước 9: thu dọn dụng cụ phân loại rác, rửa tay, ghi hồ sơ bệnh án.

Kết thúc quy trình

- Đánh giá lại tình trạng người bệnh và kết quả kỹ thuật; bảo đảm tư thế an toàn, thu gom dụng cụ và vệ sinh tay.

- Ghi thời gian, nội dung thực hiện, thuốc/dịch và thông số thực tế nếu có, đáp ứng và bất thường; bàn giao người bệnh và kế hoạch theo dõi cho nhân viên hoặc bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi trong quá trình tiêm

Quan sát sắc mặt, tổng trạng người bệnh, nếu có bất thường (dấu hiệu sốc phản vệ), báo bác sĩ và xử trí theo phác đồ cấp cứu chống shock.

7.2. Theo dõi sau tiêm

- Nghỉ ngơi tại chỗ 15 - 30 phút, theo dõi chảy máu nơi tiêm, ban sẩn dị ứng tại chỗ hoặc toàn thân.

- Phản vệ, dị ứng thuốc: xử trí theo phác đồ cấp cứu chống sốc phản vệ.

11

- Chảy máu, tụ máu nơi tiêm: cần vệ sinh tại chỗ, dùng bông vô khuẩn khô băng ép lại.

- Nhiễm khuẩn hoặc áp xe nơi tiêm: báo bác sĩ, theo dõi và chăm sóc theo chỉ định; không tự trích rạch. Gãy kim: dừng thủ thuật, cố định vùng tổn thương, báo bác sĩ để lấy kim an toàn; không dò tìm kim sâu trong mô.

- Tắc mạch: do tiêm thuốc dầu vào mạch máu hoặc liệt do tiêm vào dây thần kinh hông to.

- Phòng tránh: tiêm vào đúng vị trí, thử trước khi tiêm. Xơ hoá cơ vùng tiêm đặc biệt xơ hóa cơ delta ở trẻ em và trẻ nhỏ khi tiêm bắp vào cánh tay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế (2023), Quyết định số 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (căn cứ cấu trúc và định dạng).

2. Trần Thị Thuận (2007), Điều dưỡng cơ bản II, trang 293 - 310.

3. CDC. Vaccine Administration, General Best Practice Guidelines for Immunization. https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/imz-best-practices/vaccine-administration.html

Phụ lục

Danh mục chuẩn bị để thực hiện kỹ thuật tiêm bắp

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		
2.1	Thuốc tiêm theo chỉ định của bác sĩ		Theo chỉ định
2.2	Nước cất 5 mL	Ống	01
2.3	Cồn 70%	Chai	01
2.4	Hộp chống sốc	Hộp	01
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Bơm tiêm 5 mL, 10 mL, kim rút thuốc số 18, Pen, ống cắm pen	Cái	01
3.2	Găng tay sạch	Đôi	01
3.3	Gạc, bông	Miếng	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Mâm tiêm thuốc, Hộp đựng vật sắc nhọn, thùng đựng rác	Cái	01

12

3. QUY TRÌNH KỸ THUẬT TIÊM DƯỚI DA

1. ĐẠI CƯƠNG

Tiêm dưới da là kỹ thuật đưa thuốc dưới dạng hoà tan trong nước vào tổ chức dưới da cho thuốc hấp thu chậm vào cơ thể.

2. CHỈ ĐỊNH

- Thuốc được chỉ định và cho phép sử dụng đường dưới da theo hướng dẫn của chế phẩm.

- Tiêm Insulin trong điều trị bệnh tiểu đường.

- Các thuốc khác dùng đường dưới da theo chỉ định và hướng dẫn sử dụng; không coi atropin là thuốc giảm đau dùng thường quy.

- Vắc xin chỉ dùng đường dưới da khi hướng dẫn của đúng loại vắc xin quy định đường này; không áp dụng chung cho mọi vắc xin.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Một số thuốc dầu khó tan, ví dụ: Testosteron...

- Da có vấn đề không thuận lợi để tiêm như nứt nẻ.

4. THẬN TRỌNG

Không nên tiêm vào cùng một vị trí với mỗi lần tiêm, không tiêm vào các khu vực bị bầm tím hay có mô sẹo trên da.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện: điều dưỡng 1 người.

5.2. Thuốc

- Theo chỉ định của bác sĩ, hộp chống sốc.

- Nước cất 5 mL, dung dịch sát trùng: cồn 70%

- Dung dịch sát trùng tay nhanh.

5.3. Vật tư

- Bơm tiêm và kim phù hợp chế phẩm; insulin dùng bơm tiêm hoặc bút tiêm tương thích nồng độ insulin. Bông/gạc, hộp đựng bông cồn; không dùng vật tư pha thử phản ứng trong quy trình tiêm dưới da.

- Găng tay, băng keo.

5.4. Trang thiết bị

- Mâm tiêm thuốc.

- Pen, ống cắm pen.

- Hộp đựng vật sắc nhọn, thùng đựng rác thải theo quy định.

5.5. Người bệnh

- Nhận định tình trạng người bệnh, hỏi về tiền sử liên quan đến kỹ thuật.

13
- Giải thích về kỹ thuật sắp làm: mục đích , các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra, tiên lượng…

- Hướng dẫn những điều cần thiết (nếu cần).

5.6. Hồ sơ bệnh án: phiếu chăm sóc.

5.7. Thời gian thực hiện: dự kiến 0,08–0,17 giờ.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Kiểm tra người bệnh.

- Thực hiện 5 đúng.

- Thực hiện bảng kiểm an toàn kỹ thuật.

- Cho người bệnh nằm tư thế thoải mái.

- Xác nhận đúng người bệnh bằng ít nhất hai thông tin nhận diện, đúng chỉ định và vị trí; kiểm tra dị ứng và nguy cơ liên quan. Thực hiện bảng kiểm an toàn phù hợp, giải thích và đặt tư thế trước kỹ thuật.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: điều dưỡng rửa tay thường quy.

- Bước 2: thực hiện 5 đúng.

- Bước 3: pha và lấy thuốc đúng kỹ thuật.

- Bước 4: kiểm tra thuốc trước khi bỏ vỏ ống thuốc.

- Bước 5: xác định đúng vị trí tiêm, sát khuẩn vị trí tiêm.

- Bước 6: sát khuẩn tay nhanh mang găng tay (nếu cần thiết).

- Bước 7: nâng nếp da và chọn góc tiêm 45° hoặc 90° theo chiều dài kim, bề dày mô dưới da và hướng dẫn chế phẩm. Tiêm đúng kỹ thuật, quan sát người bệnh; với insulin dùng kim bút ngắn thực hiện theo hướng dẫn nhà sản xuất.

- Bước 8: rút kim tiêm an toàn.

- Bước 9: ấn gòn vào vị trí tiêm.

- Bước 10: giúp người bệnh trở về tư thế thoải mái và hướng dẫn những điều cần thiết.

- Bước 11: thu dọn dụng cụ phân loại rác, rửa tay, ghi hồ sơ bệnh án.

Kết thúc quy trình

- Đánh giá lại tình trạng người bệnh và kết quả kỹ thuật; bảo đảm tư thế an toàn, thu gom dụng cụ và vệ sinh tay.

- Ghi thời gian, nội dung thực hiện, thuốc/dịch và thông số thực tế nếu có, đáp ứng và bất thường; bàn giao người bệnh và kế hoạch theo dõi cho nhân viên hoặc bộ phận tiếp theo khi cần.

14

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

- Quan sát sắc mặt, tổng trạng người bệnh, nếu có bất thường (dấu hiệu sốc phản vệ), báo bác sĩ.

- Theo dõi sau tiêm: nghỉ ngơi tại chỗ 15 - 30 phút, theo dõi chảy máu nơi tiêm.

- Sốc phản vệ, dị ứng thuốc: xử trí theo phác đồ cấp cứu chống sốc phản vệ.

- Chảy máu, tụ máu nơi tiêm: cần vệ sinh tại chỗ, dùng bông vô khuẩn khô băng ép lại.

- Nhiễm khuẩn hoặc áp xe: báo bác sĩ, theo dõi và chăm sóc theo chỉ định; không tự trích rạch.

- Gãy kim: dừng thủ thuật, cố định vùng tổn thương và báo bác sĩ; không dò tìm kim sâu trong mô.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế (2023), Quyết định số 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (căn cứ cấu trúc và định dạng).

2. Trần Thị Thuận (2007), Điều dưỡng cơ bản II, trang 293 - 310.

3. CDC. Chapter 6 Vaccine Administration, Pink Book. https://www.cdc.gov/pinkbook/hcp/table-of-contents/chapter-6-vaccine-administration.html

Phụ lục

Danh mục chuẩn bị để thực hiện kỹ thuật tiêm dưới da

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		
2.1	Thuốc tiêm theo chỉ định của bác sĩ		Theo chỉ định
2.2	Cồn 70%	Chai	01
2.3	Nước cất 5 mL	Ống	01
2.4	Hộp chống sốc	Hộp	01
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Bơm tiêm 1 mL, 10 mL, kim rút thuốc số 18	Cái	01
3.2	Găng tay sạch	Đôi	01
3.3	Gạc, gòn	Miếng	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		

15

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
4.1	Pen, ống cắm pen	Cái	01
4.2	Mâm tiêm thuốc	Cái	01
4.3	Hộp đựng vật sắc nhọn, thùng đựng rác	Cái	01

16

4. QUY TRÌNH TIÊM TRONG DA

1. ĐẠI CƯƠNG

Tiêm trong da là kỹ thuật đưa lượng nhỏ chế phẩm vào lớp bì, dùng cho một số thử nghiệm da hoặc vắc xin theo hướng dẫn chuyên biệt. Liều và thể tích phụ thuộc chế phẩm, không mặc định 0,1 mL cho mọi đối tượng.

2. CHỈ ĐỊNH

- Thử nghiệm da với thuốc chỉ thực hiện khi có chỉ định phù hợp và theo quy trình thử phản ứng riêng; không thử phản ứng thường quy cho tất cả thuốc.

- Việc lựa chọn thuốc, nồng độ thử và cách đọc kết quả do bác sĩ có chuyên môn chỉ định; kết quả âm tính không loại trừ hoàn toàn phản vệ.

- Không dùng quy trình tiêm trong da này để thay thế hướng dẫn chuyên biệt của huyết thanh, thuốc kháng nọc hoặc từng chế phẩm.

- Phòng bệnh: tiêm vacxin BCG phòng lao cho trẻ sơ sinh.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không thử phản ứng khi người bệnh đang có cơn dị ứng cấp tính: viêm mũi, nổi mề đay, hen phế quản.

4. THẬN TRỌNG

Không nên tiêm vào cùng một vị trí với mỗi lần tiêm, không tiêm vào các khu vực bị bầm tím hay có mô sẹo trên da.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện: điều dưỡng 1 người

5.2. Thuốc:

- Theo chỉ định của bác sĩ. Hộp chống sốc, nước cất 5 mL (trong trường hợp thử phản ứng), dung dịch sát trùng: cồn 70%

- Dung dịch sát trùng tay nhanh.

5.3. Vật tư:

- Bơm tiêm 1 mL, (bơm 10 mL nếu pha thử test), kim rút thuốc số 18, gòn, gạc miếng, hộp đựng bông có cồn.

- Găng tay, băng keo.

5.4. Trang thiết bị:

- Mâm tiêm thuốc, pen, ống cắm pen, hộp đựng vật sắc nhọn, thùng đựng rác thải theo quy định.

- Bút ghi (trong trường hợp thử phản ứng).

5.5. Người bệnh

- Nhận định tình trạng người bệnh, hỏi về tiền sử liên quan đến kỹ thuật.

17
- Giải thích về kỹ thuật sắp làm: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra, tiên lượng…

- Hướng dẫn những điều cần thiết (nếu cần).

5.6. Hồ sơ bệnh án

Phiếu chăm sóc, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: ghi thời gian thực tế bằng giờ; định mức thời gian do bệnh viện xác nhận theo phương pháp và tình trạng người bệnh.

5.8. Địa điểm được thực hiện kỹ thuật: phòng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Kiểm tra người bệnh.

- Thực hiện 5 đúng.

- Thực hiện bảng kiểm an toàn kỹ thuật.

- Cho người bệnh nằm thoải mái.

- Xác nhận đúng người bệnh bằng ít nhất hai thông tin nhận diện, đúng chỉ định và vị trí; kiểm tra dị ứng và nguy cơ liên quan. Thực hiện bảng kiểm an toàn phù hợp, giải thích và đặt tư thế trước kỹ thuật.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: điều dưỡng rửa tay thường quy.

- Bước 2: thực hiện 5 đúng.

- Bước 3: pha và lấy thuốc đúng kỹ thuật, kiểm tra thuốc trước khi bỏ vỏ thuốc.

- Bước 4: xác định đúng vị trí tiêm, sát khuẩn vị trí tiêm.

- Bước 5: sát khuẩn tay nhanh và mang găng tay.

- Bước 6: căng da, đưa kim nông với mặt vát ngửa vào lớp bì theo kỹ thuật của chế phẩm; tiêm đúng thể tích được chỉ định, quan sát sẩn tại chỗ. Không xoa bóp; nếu thử nghiệm da, đánh dấu vị trí và đọc theo quy trình chuyên biệt.

- Bước 7: rút kim, giúp người bệnh trở về tư thế thoải mái và hướng dẫn những điều cần thiết.

- Bước 8: thu dọn dụng cụ phân loại rác, rửa tay, ghi hồ sơ bệnh án.

Kết thúc quy trình

- Đánh giá lại tình trạng người bệnh và kết quả kỹ thuật; bảo đảm tư thế an toàn, thu gom dụng cụ và vệ sinh tay.

- Ghi thời gian, nội dung thực hiện, thuốc/dịch và thông số thực tế nếu có, đáp ứng và bất thường; bàn giao người bệnh và kế hoạch theo dõi cho nhân viên hoặc bộ phận tiếp theo khi cần.

18

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi trong quá trình tiêm

Quan sát sắc mặt, tổng trạng người bệnh, nếu có bất thường (dấu hiệu sốc phản vệ) báo bác sĩ.

7.2. Theo dõi sau tiêm

Nghỉ ngơi tại chỗ 15 - 30 phút, theo dõi chảy máu nơi tiêm

- Sốc phản vệ, dị ứng thuốc: xử trí theo phác đồ cấp cứu chống sốc phản vệ.

- Chảy máu, tụ máu nơi tiêm: cần vệ sinh tại chỗ, dùng bông vô khuẩn khô băng ép lại.

- Nghi nhiễm khuẩn hoặc áp xe tại chỗ: báo bác sĩ, theo dõi và chăm sóc theo chỉ định; không tự trích rạch.

- Gẫy kim: rút kim bằng pen vô khuẩn nếu kim chưa ngập sâu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế (2023), Quyết định số 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (căn cứ cấu trúc và định dạng).

2. Trần Thị Thuận (2007), Điều dưỡng cơ bản II, trang 293 - 310.

Phụ lục

Danh mục chuẩn bị để thực hiện quy trình tiêm trong da

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		
2.1	Thuốc tiêm theo chỉ định của bác sĩ		Theo chỉ định
2.2	Cồn 70%	Chai	01
2.3	Nước cất 5 mL	Ống	01
2.4	Hộp chống sốc	Hộp	01
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Bơm tiêm 1 mL, 10 mL, kim rút thuốc số 18	Cái	01
3.2	Găng tay vô khuẩn	Đôi	01
3.3	băng keo, gạc, gòn	Miếng	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Pen, ống cắm pen, bút ghi	Cái	01

19

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
4.2	Mâm tiêm thuốc	Cái	01
4.3	Hộp đựng vật sắc nhọn, thùng đựng rác	Cái	01

20

5. QUY TRÌNH TIÊM TĨNH MẠCH, TRUYỀN TĨNH MẠCH

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: là cách thức đưa thuốc nhanh vào cơ thể qua đường tĩnh mạch ngoại biên.

- Nguyên tắc chung:

+ Thực hiện theo đúng các bước kỹ thuật.

+ Đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn: rửa tay, bơm kim tiêm dùng một lần...

+ Thực hiện 5 đúng.

+ Phát hiện tai biến và xử lý đúng khi tiêm.

2. CHỈ ĐỊNH

- Cần có tác dụng nhanh của thuốc với cơ thể.

- Cần đưa và cơ thể khối lượng thuốc nhiều.

- Những thuốc gây hoại tử da, tổ chức dưới da, cơ (canxiclorua).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không sử dụng đường tĩnh mạch với chế phẩm không được phép dùng đường này. Không chọc vào vùng bỏng, nhiễm khuẩn hoặc tĩnh mạch tổn thương; lựa chọn đường truyền và cách dùng theo đặc tính từng thuốc.

4. THẬN TRỌNG

Kiểm tra tiền sử dị ứng, nồng độ pha, dung môi, tương hợp, tốc độ và đường truyền theo hướng dẫn thuốc. Thuốc kích ứng, gây hoại tử hoặc ảnh hưởng huyết động cần đường truyền và theo dõi phù hợp theo chỉ định; không áp dụng chống chỉ định chung cho mọi thuốc có nguy cơ loạn nhịp.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện: điều dưỡng 1 người.

5.2. Thuốc: theo chỉ định của bác sĩ, hộp chống sốc, dung môi, nước cất pha tiêm 5 mL, đường glucose 5%, Natri clorid 0,9% (có chỉ định pha tiêm) cồn 70%.

5.3. Vật tư

- Bơm kim tiêm 5 mL, kim bướm, kim luồn các cỡ phù hợp tuổi.

- Gòn, gạc, hộp đựng gòn gạc.

- Găng tay sạch, dây garo.

5.4. Trang thiết bị

- Mâm tiêm thuốc.

- Pen, ống cắm pen.

- Thùng đực rác thải theo quy định.

- Hộp đựng vật sắc nhọn.

21

5.5. Người bệnh

- Giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh.

- Giải thích về kỹ thuật sắp làm: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra, tiên lượng…

- Hướng dẫn những điều cần thiết (nếu cần).

5.6. Hồ sơ bệnh án

Phiếu chăm sóc.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: dự kiến 0,08–0,17 giờ.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Kiểm tra người bệnh.

- Thực hiện 5 đúng.

- Thực hiện bảng kiểm an toàn kỹ thuật.

- Cho người bệnh nằm ngửa thoải mái.

- Xác nhận đúng người bệnh bằng ít nhất hai thông tin nhận diện, đúng chỉ định và vị trí; kiểm tra dị ứng và nguy cơ liên quan. Thực hiện bảng kiểm an toàn phù hợp, giải thích và đặt tư thế trước kỹ thuật.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: thực hiện 5 bước (đúng người bệnh, đúng thuốc, đúng liều dùng, đúng đường dùng, đúng thời gian).

- Bước 2: rửa tay thường quy hoặc sát khuẩn tay nhanh.

- Bước 3: sát khuẩn nắp lọ thuốc, dung môi.

- Bước 4: pha thuốc và lắc đều; Quan sát chất lượng thuốc: màu sắc, tính chất ...

- Bước 5: rút thuốc đúng chỉ định, đuổi khí.

- Bước 6: tìm vị trí tiêm thích hợp, hướng dẫn người nhà cách bế trẻ (nếu là trẻ nhỏ).

- Bước 7: buộc dây garo.

- Bước 8: sát khuẩn nơi tiêm bông thấm cồn 70%, để da khô.

- Bước 9: luồn kim vào trong lòng tĩnh mạch. Một tay đỡ dưới vị trí tiêm (tay hoặc chân) căng da vùng tiêm, tay còn lại cầm kim mũi vát ngửa lên trên, đâm kim với góc chếch khoảng 15 - 30°. Khi thấy có máu trào ra vùng đốc kim thì hạ thấp kim tiêm luồn vào tĩnh mạch rồi dừng lại.

- Bước 10: tháo dây garo bơm thuốc thật từ từ theo chỉ định bác sĩ. Quan sát thật kỹ người bệnh trong quá trình tiêm.

- Bước 11: rút kim nhanh, căng da và đặt bông gòn vào nơi tiêm khi hết thuốc.

- Thực hành kỹ thuật tiêm tĩnh mạch khi người bệnh đang truyền dịch cần chú ý:

22
+ Không cần buộc dây garo nhưng phải chú ý khóa lại dịch truyền.

+ Sát khuẩn cổng tiêm hoặc đầu nối theo hướng dẫn thiết bị, để khô; sử dụng cổng không kim khi có và bảo đảm tương hợp thuốc–dịch truyền.

+ Tiêm qua cổng thích hợp theo hướng dẫn của hệ thống; không chọc thủng dây truyền hoặc dùng thuật ngữ "đầu Ambu" thay cho cổng tiêm.

+ Mở khoá cho dịch chảy theo y định của bác sĩ.

- Bước 12: giúp người bệnh trở về tư thế thoải mái.

- Bước 13: dặn người bệnh, gia đình người bệnh những điều cần thiết (khó thở, sắc mặt, tri giác).

- Bước 14: thu dọn dụng cụ phân loại rác, rửa tay và ghi hồ sơ bệnh án.

Kết thúc quy trình

- Đánh giá lại tình trạng người bệnh và kết quả kỹ thuật; bảo đảm tư thế an toàn, thu gom dụng cụ và vệ sinh tay.

- Ghi thời gian, nội dung thực hiện, thuốc/dịch và thông số thực tế nếu có, đáp ứng và bất thường; bàn giao người bệnh và kế hoạch theo dõi cho nhân viên hoặc bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

- Theo dõi trong quá trình tiêm: quan sát sắc mặt người bệnh, nếu có dấu hiệu sốc phản vệ, dừng tiêm, báo bác sĩ xử trí theo phác đồ. Trong quá trình tiêm có thể xảy ra tắc kim tiêm, phồng nơi tiêm, người bệnh hoảng sợ ...

- Theo dõi sau tiêm: phản ứng dị ứng muộn: nổi mẩn tại chỗ tiêm hoặc toàn thân.

- Tắc kim/catheter: dừng sử dụng, kiểm tra nguyên nhân và báo người phụ trách; không cố bơm mạnh, không đẩy cục máu đông vào mạch. Thay đường truyền khi cần theo quy trình.

- Đau, sưng hoặc nghi thoát mạch: dừng tiêm/truyền và gọi hỗ trợ, không bơm rửa. Với thuốc gây tổn thương mô, giữ catheter để xử trí theo phác đồ riêng của thuốc trước khi quyết định rút; ghi nhận vùng tổn thương và báo bác sĩ.

- Người bị bệnh ngất, hoảng sợ: cần làm tốt công tác tâm lý cho người bệnh trước khi tiêm thuốc.

- Tắc mạch: nguyên nhân do không khí ở trong bơm tiêm vào lòng mạch, tiêm nhầm thuốc tan trong dầu, dạng sữa. Đề phòng đuổi hết không khí trong bơm tiêm trước khi tiêm thuốc cho người bệnh. Chú ý 5 đúng tránh nhầm thuốc.

- Nhiễm khuẩn: nguyên nhân do vô khuẩn không tốt, lưu kim kéo dài. Đề phòng: Thực hiện tốt công tác vô khuẩn trước, trong và sau khi tiêm thuốc cho người bệnh. Ghi nhớ thời gian lưu kim.

- Sốc phản vệ: nguyên nhân do phản ứng của cơ thể với thuốc. Biểu hiện: bồn chồn, hốt hoảng, sợ hãi, kích thích li bì hoặc hôn mê, mạch nhanh nhỏ, khó bắt, khó thở, tím tái. Nhẹ hơn là mẩn ngứa, ban đỏ, mày đay dị ứng. Xử trí: ngừng tiêm, xử trí theo phác đồ cấp cứu sốc phản vệ.

23

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế (2023), Quyết định số 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (căn cứ cấu trúc và định dạng).

2. Trần Thị Thuận (2007), Điều dưỡng cơ bản II, trang 293 - 310, trang 330 - 336.

3. Cancer Institute NSW, eviQ. Extravasation management clinical procedure. https://www.eviq.org.au/clinical-resources/extravasation/4156-extravasation-management-clinical-procedure

Phụ lục

Danh mục chuẩn bị để thực hiện quy trình tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		
2.1	Thuốc tiêm theo chỉ định của bác sĩ		Theo chỉ định
2.2	Hộp chống sốc	Cái	01
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Bơm tiêm 5 mL, kim rút thuốc 18	Cái	01
3.2	Găng tay vô khuẩn	Đôi	01
3.3	Cồn 70%	Chai	01
3.4	Gạc, băng keo	Miếng	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Pen, ống cắm pen	Cái	01
4.2	Mâm tiêm thuốc	Cái	01
4.3	Hộp đựng vật sắc nhọn, thùng đựng rác	Cái	01

24

6. QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGHIỆM PHÁP DÂY THẮT

1. ĐẠI CƯƠNG

Nghiệm pháp dây thắt (Tourniquet test) là một phương pháp chẩn đoán đơn giản nhằm đánh giá tình trạng tăng tính thấm thành mạch, thường được áp dụng trong các trường hợp nghi ngờ bệnh sốt xuất huyết Dengue. Nguyên lý dựa trên việc làm tăng áp lực mao mạch bằng cách thắt tĩnh mạch cánh tay, từ đó quan sát sự xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da.

Mục đích: giúp sàng lọc và hỗ trợ chẩn đoán các bệnh lý gây xuất huyết dưới da, đặc biệt là sốt xuất huyết Dengue.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh nghi ngờ mắc sốt xuất huyết Dengue (theo tiêu chuẩn lâm sàng). Cần đánh giá mức độ xuất huyết dưới da trong một số bệnh lý huyết học.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh đang có xuất huyết tự nhiên hoặc đã có dấu hiệu xuất huyết dưới da rõ ràng. Người bệnh đang trong tình trạng sốc. Người bệnh có bệnh lý da tại vị trí thực hiện (viêm da, nhiễm trùng,…).

- Có chống chỉ định làm tăng áp lực vùng chi trên (như huyết khối tĩnh mạch sâu, tổn thương cánh tay).

4. THẬN TRỌNG

Không nên thực hiện kỹ thuật ở trẻ dưới 3 tuổi. Không thắt quá chặt hoặc để quá lâu để tránh gây tổn thương mô mềm. Phải theo dõi chặt chẽ phản ứng của người bệnh trong và sau khi thực hiện.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp: điều dưỡng có chuyên môn, được đào tạo về kỹ thuật.

b) Nhân lực hỗ trợ: Không bắt buộc (nếu người bệnh hợp tác tốt).

5.2. Thuốc

Không sử dụng thuốc trong kỹ thuật này.

5.3. Vật tư

Máy đo huyết áp với bao quấn phù hợp, bút đánh dấu da, thước đo và đồng hồ bấm giờ; không thay bao đo huyết áp bằng dây garo không kiểm soát được áp lực.

5.4. Trang thiết bị

Giường bệnh hoặc ghế tựa. Đèn chiếu sáng (nếu cần).

5.5. Người bệnh

Được giải thích quy trình, đồng ý hợp tác. Ở tư thế ngồi hoặc nằm thoải mái.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án có ghi nhận chỉ định thực hiện nghiệm pháp dây thắt.

25

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Ước tính: 20 phút (bao gồm chuẩn bị, thực hiện và ghi nhận kết quả).

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng khám, phòng cấp cứu, buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

Đảm bảo có chỉ định của bác sĩ, không có chống chỉ định.

- Xác nhận đúng người bệnh bằng ít nhất hai thông tin nhận diện, đúng chỉ định và vị trí; kiểm tra dị ứng và nguy cơ liên quan. Thực hiện bảng kiểm an toàn phù hợp, giải thích và đặt tư thế trước kỹ thuật.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Các bước thực hiện

- Bước 1: giải thích kỹ thuật cho người bệnh và cho họ nằm hoặc ngồi thoải mái.

- Bước 2: đeo găng tay, xác định vị trí mặt trước cẳng tay không bị tổn thương.

- Bước 3: quấn bao đo huyết áp quanh cánh tay người bệnh và bơm lên mức trung bình giữa huyết áp tối đa và tối thiểu.

- Bước 4: giữ nguyên áp lực trong 5 phút.

- Bước 5: tháo bao, đợi khoảng 2 phút

- Bước 6: đếm số chấm xuất huyết trên diện tích 2,5 cm x 2,5 cm, ghi nhận kết quả.

- Bước 7: đánh giá kết quả:

+ Nghiệm pháp dương tính: ≥20 chấm xuất huyết.

+ Nghiệm pháp âm tính: <20 chấm.

- Bước 8: kết thúc quy trình.

6.2. Ghi hồ sơ

Ghi nhận ngày giờ thực hiện, kết quả, tên người thực hiện vào hồ sơ bệnh án.

Kết thúc quy trình

- Đánh giá lại tình trạng người bệnh và kết quả kỹ thuật; bảo đảm tư thế an toàn, thu gom dụng cụ và vệ sinh tay.

- Ghi thời gian, nội dung thực hiện, thuốc/dịch và thông số thực tế nếu có, đáp ứng và bất thường; bàn giao người bệnh và kế hoạch theo dõi cho nhân viên hoặc bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

- Đau, khó chịu do thắt bao quá chặt.

- Bầm tím hoặc xuất huyết lan rộng nếu có rối loạn đông máu.

26

7.2. Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

- Phù cánh tay tạm thời.

- Đau nhức nhẹ vùng thắt dây.

7.3. Biến chứng muộn

Hiếm gặp: có thể xuất hiện bầm tím kéo dài nếu người bệnh có bệnh lý nền đông máu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế (2023), Quyết định số 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (căn cứ cấu trúc và định dạng).

2. WHO Dengue Guidelines for Diagnosis, Treatment, Prevention and Control, 2009.

Phụ lục

Danh mục chuẩn bị để thực hiện quy trình nghiệm pháp dây thắt

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng thực hiện kỹ thuật	Người	1
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		
2.1	Không sử dụng		
3	Vật tư (sử dụng trực tiếp)		
3.1	Bao quấn huyết áp đúng kích cỡ	Cái	01
3.2	Găng tay sạch	Đôi	1
3.3	Bút đánh dấu da	Cái	1
3.4	Đồng hồ bấm giờ	Cái	1
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Máy đo huyết áp	Cái	01

27

7. QUY TRÌNH KỸ THUẬT LẤY ĐỜM BẰNG TÁC ĐỘNG VỖ RUNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Lấy đờm bằng tác động vỗ rung là kỹ thuật hỗ trợ dẫn lưu và tống xuất đờm từ phổi ra ngoài bằng các biện pháp cơ học như vỗ lồng ngực kết hợp rung để làm long đờm. Kỹ thuật này giúp cải thiện thông khí, giảm nguy cơ tắc nghẽn đường thở, hỗ trợ điều trị các bệnh lý đường hô hấp có tăng tiết đờm như viêm phổi, COPD, giãn phế quản.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh đặt ống nội khí quản, mở khí quản..

- Các bệnh về phổi: viêm phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), áp xe phổi, hen phế quản...

- Người bệnh nằm lâu ngày ít cử động: người bệnh hôn mê, liệt.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương sườn, loãng xương nặng.

- Chấn thương lồng ngực, phổi.

- Có khối u, tổn thương da tại vùng ngực cần vỗ.

- Sau phẫu thuật lồng ngực chưa ổn định.

- Tăng áp lực nội sọ, chảy máu phổi, tràn khí màng phổi chưa dẫn lưu.

4. THẬN TRỌNG

- Cần xác định đúng vị trí vỗ để đạt hiệu quả dẫn lưu.

- Không vỗ sau khi người bệnh ăn no (nên thực hiện trước bữa ăn 1 giờ hoặc sau ăn ít nhất 2 giờ).

- Theo dõi người bệnh trong quá trình thực hiện để ngưng kỹ thuật nếu có dấu hiệu bất thường như khó thở, tím tái.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

01 điều dưỡng đã được đào tạo kỹ thuật vỗ rung lấy đờm.

5.2. Thuốc

Natri clorid 0,9%.

5.3. Vật tư

- Khẩu trang y tế, găng tay sạch.

- Khăn giấy sạch hoặc khăn vải.

5.4. Trang thiết bị

Khay hạt đậu hoặc bô/chậu đựng đờm, túi rác y tế.

28

5.5. Người bệnh

Được giải thích về thủ thuật, hợp tác tốt.

Mặc quần áo rộng rãi, thoải mái.

Nghỉ ngơi yên tĩnh ít nhất 15 - 30 phút trước thực hiện.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án hoặc bảng theo dõi điều dưỡng có chỗ ghi nhận kết quả thực hiện kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Ước tính: 0,5 giờ (bao gồm chuẩn bị, thực hiện và ghi nhận kết quả).

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng khám, phòng cấp cứu, buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

Đảm bảo có chỉ định của bác sĩ, không có chống chỉ định.

- Xác nhận đúng người bệnh bằng ít nhất hai thông tin nhận diện, đúng chỉ định và vị trí; kiểm tra dị ứng và nguy cơ liên quan. Thực hiện bảng kiểm an toàn phù hợp, giải thích và đặt tư thế trước kỹ thuật.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: giải thích thủ thuật cho người bệnh để tạo sự hợp tác.

- Bước 2: cho người bệnh nằm hoặc ngồi ở tư thế phù hợp tùy vùng phổi cần dẫn lưu.

- Bước 3: điều dưỡng rửa tay, mang găng sạch và khẩu trang.

- Bước 4: xác định vùng phổi cần dẫn lưu, vỗ đúng vùng, tránh vùng xương ức, xương sống, xương bả vai, thận.

- Bước 5: dùng bàn tay chụm lại thành hình chén, vỗ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đều tay lên vùng cần vỗ trong 3 - 5 phút.

- Bước 6: kết hợp rung ngực (nếu có thể): khi người bệnh hít vào sâu, điều dưỡng ép nhẹ bàn tay lên thành ngực theo nhịp thở ra để hỗ trợ đẩy đờm ra ngoài.

- Bước 7: khuyến khích người bệnh ho mạnh để tống đờm ra ngoài.

- Bước 8: hỗ trợ người bệnh khạc đờm vào khăn giấy, khay hoặc dụng cụ đựng đờm.

- Bước 9: lau sạch vùng da vỗ rung nếu có mồ hôi hoặc chất tiết.

- Bước 10: thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.

Kết thúc quy trình

- Đánh giá lại tình trạng người bệnh và kết quả kỹ thuật; bảo đảm tư thế an toàn, thu gom dụng cụ và vệ sinh tay.

29
- Ghi thời gian, nội dung thực hiện, thuốc/dịch và thông số thực tế nếu có, đáp ứng và bất thường; bàn giao người bệnh và kế hoạch theo dõi cho nhân viên hoặc bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi: sát mạch, SpO_2, nhịp thở của người bệnh trước, trong và sau khi tiến hành vỗ rung.

7.2. Xử trí tai biến

- Suy hô hấp: SpO_2 tụt, sắc mặt tím tái,thở nhanh hoặc chậm... Ngừng vỗ rung, cho người bệnh về tư thế thích hợp, tăng oxy và hút đờm (nếu cần).

- Chấn thương lồng ngực do kỹ thuật thô bạo: Khi vỗ phải đảm bảo đúng kỹ thuật.

- Một số chú ý khi vỗ, rung:

+ Tổng thời gian vỗ và rung không quá 30 - 40 phút. Khi tiến hành phải luôn theo dõi sát mạch, nhịp thở, SpO_2, sắc mặt người bệnh.

+ Khi vỗ rung nhắc người bệnh nhịn ho (nếu người bệnh tỉnh) đến khi mắc ho nhiều thì gắng sức ho khạc cho đờm, mủ tống ra được nhiều. Vỗ rung xong nên hút đờm ngay bên vừa vỗ rung rồi mới sang bên kia.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế (2023), Quyết định số 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (căn cứ cấu trúc và định dạng).

2. Trần Thị Thuận (2007), Điều dưỡng cơ bản II, trang 212 - 216.

Phụ lục

Danh mục chuẩn bị để thực hiện quy trình kỹ thuật

lấy đờm bằng tác động vỗ rung

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	01 Điều dưỡng đã được đào tạo	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		
2.1	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh, Xà phòng diệt khuẩn	Chai	01
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Găng tay sạch	Đôi	02
3.2	Khăn bông to, Mũ, Khẩu trang	Cái	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Bóng, Mask	Cái	01

30

8. QUY TRÌNH TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH NGỘ ĐỘC

1. ĐẠI CƯƠNG

- Tư vấn là phần rất quan trọng trong khi chẩn đoán và điều trị người bệnh nói chung và đặc biệt là trong ngộ độc. Người thực hiện tốt nhất của người bệnh chính là bản thân họ. Nhiệm vụ của người bác sĩ là giải thích để người bệnh hiểu điều đó và phối hợp trong điều trị bệnh.

- Đối với người bệnh ngộ độc, tùy theo nguyên nhân ngộ độc để có cách tư vấn hợp lý. Người bệnh tự tử thường có vấn đề về tâm thần, cần khai thác và hội chẩn thêm chuyên khoa Tâm thần.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh ngộ độc (tỉnh táo, nói chuyện tiếp xúc được).

- Một số thành viên trong gia đình người bệnh.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định.

4. THẬN TRỌNG

Tư vấn khi người bệnh đủ ổn định để tiếp nhận thông tin; không làm chậm cấp cứu. Bảo đảm riêng tư, giao tiếp không phán xét; người có nguy cơ tự hại cần đánh giá và phối hợp chuyên khoa.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

1 Bác sĩ, 1 điều dưỡng: quần áo, đội mũ,đeo khẩu trang (trong một số trường hợp người bệnh có nguy cơ bệnh lây nhiễm).

5.2. Thuốc: dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

5.3. Vật tư

- Khẩu trang phẫu thuật: 2 cái.

- Mũ phẫu thuật: 2 cái.

- Găng tay: 2 đôi.

5.4. Trang thiết bị

- Giường bệnh, cáng nếu người bệnh đang nằm viện.

- Phòng tư vấn riêng (nếu người bệnh tới khám tư vấn): không gian yên tĩnh, có điều hòa nhiệt độ hoặc mát mẻ về mùa Hè, ấm về mùa Đông.

- Bàn ghế cho bác sĩ, ghế cho người bệnh và người nhà người bệnh, có một số tờ rơi, poster, có thể có băng đĩa hình, đầu quay video về phòng tránh ngộ độc chung và một số ngộ độc thông thường, một số thông tin về bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe định kỳ.

31
- Tài liệu tư vấn sử dụng phù hợp nhu cầu người bệnh. Các chi phí quản lý như điện, nước, khấu hao không đưa vào danh mục trang thiết bị sử dụng trực tiếp của kỹ thuật.

5.5. Người bệnh

Người bệnh đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt nằm trên giường bệnh hoặc ngồi ghế để nghe và nói chuyện cùng người thực hiện.

5.6. Hồ sơ bệnh án: ghi rõ chẩn đoán, nguyên nhân ngộ độc và đánh giá tổn thương.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Ước tính: 0,5 giờ (bao gồm chuẩn bị, thực hiện và ghi nhận kết quả).

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng khám, phòng cấp cứu, buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

Đảm bảo có chỉ định của bác sĩ, không có chống chỉ định.

- Xác nhận đúng người bệnh bằng ít nhất hai thông tin nhận diện, đúng chỉ định và vị trí; kiểm tra dị ứng và nguy cơ liên quan. Thực hiện bảng kiểm an toàn phù hợp, giải thích và đặt tư thế trước kỹ thuật.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Đề nghị người bệnh hoặc người nhà nêu vấn đề cần hỏi. Bác sĩ trả lời, giải thích các câu hỏi của người bệnh. Mở rộng các vấn đề liên quan tới câu hỏi của người bệnh để hướng dẫn phòng tránh và điều trị hợp lý. Cuối buổi tư vấn cần có câu tóm tắt, kết luận về vấn đề tư vấn. Tùy theo nguyên nhân ngộ độc để có các tư vấn hợp lý.

Ví dụ:

- Nguyên nhân ngộ độc do ăn uống nhầm phải chất độc (thường gặp ở trẻ em, người già bị lẫn lộn, người bệnh tâm thần, say rượu): cần giải thích cho người bệnh và người nhà:

+ Không để các hóa chất trong gia đình (chất tẩy rửa, vệ sinh, khử mùi, xăng dầu…), các hóa chất bảo vệ thực vật (hóa chất trừ sâu, trừ cỏ, hóa chất kích thích tăng trưởng…) vào các chai lọ đựng đồ ăn, uống (chai đựng nước ngọt, nước lọc). + Có nơi quản lý riêng với các hóa chất, đặc biệt là các hóa chất bảo vệ thực vật cần có thùng hoặc kho đựng riêng, có khóa. Chỉ những người được đào tạo, được hướng dẫn đầy đủ mới được sử dụng các hóa chất đó.

+ Để xa tầm với của trẻ em tất cả các thuốc, hóa chất, cặp nhiệt độ…

+ Không đánh bả chuột ở những nơi trẻ em hay chơi đùa hoặc dễ nhìn thấy.

+ Bảo quản và chế biến thực phẩm đúng cách

- Ngộ độc do ăn phải chất độc có sẵn trong thức ăn:

+ Không ăn nấm tự hái ở rừng vì không thể phân biệt được giữa nấm lành và nấm độc. Không ăn hoa quả không rõ loại

32
+ Thu hái rau quả sau khi phun hóa chất bảo vệ thực vật đủ thời gian an toàn.

+ Không sử dụng phẩm màu công nghiệp trong chế biến thực phẩm.

- Ngộ độc do nguyên nhân tự tử: đây là nhóm người bệnh cần được tư vấn kỹ nhất và khó nhất. Tìm hiểu nguyên nhân thực sự làm người bệnh tự tử mới có thể tháo gỡ được: buồn vì bệnh tật, bị bạo hành, cưỡng bức, vì thua cờ bạc, nợ nần, mâu thuẫn trong gia đình hoặc bạn bè, đồng nghiệp, nghiện ngập…

- Người thực hiện cần có sự tôn trọng, thông cảm, chia sẻ với người bệnh. Mục đích cuối cùng là làm người bệnh có thêm nghị lực, giải tỏa được stress và có kế hoạch sống tốt hơn, cởi mở hơn khi về với cuộc sống bình thường. Khám tư vấn thêm chuyên khoa Tâm thần để cùng giúp đỡ cho người bệnh không tự tử lại, phát hiện những rối loạn tâm thần sớm để điều trị cho người bệnh (thường là mắc trầm cảm).

- Ngộ độc vì lạm dụng ma túy, rượu…đây là vấn đề không dễ giải quyết. Giải thích và phối hợp cùng gia đình, tư vấn và gợi ý một số địa chỉ các Trung tâm cai nghiện giúp người bệnh và gia đình.

- Ngộ độc do bị đầu độc: khám và đánh giá các triệu chứng khách quan, xét nghiệm độc chất, tư vấn cho gia đình và người bệnh cùng phối hợp điều trị, thông báo cho cơ quan thực thi Pháp luật.

- Sau khi tư vấn, cần hỏi lại người bệnh và người nhà người bệnh trước khi kết thúc xem người bệnh đã đồng ý với các câu trả lời chưa, đã hiểu rõ vấn đề chưa, cần thêm thông tin về ngộ độc không.

- Trong khi tư vấn cần tăng cường giáo dục về phòng tránh ngộ độc.

Kết thúc quy trình

- Đánh giá lại tình trạng người bệnh và kết quả kỹ thuật; bảo đảm tư thế an toàn, thu gom dụng cụ và vệ sinh tay.

- Ghi thời gian, nội dung thực hiện, thuốc/dịch và thông số thực tế nếu có, đáp ứng và bất thường; bàn giao người bệnh và kế hoạch theo dõi cho nhân viên hoặc bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

- Theo dõi các diễn biến tâm lý của người bệnh để điều chỉnh tư vấn cho hợp lý.

- Cần tư vấn nhiều lần.

- Tránh giải thích quá sâu chuyên môn dẫn đến lo lắng (ví dụ ít nguy cơ lại giải thích nhiều về các biến chứng nặng nề, ung thư hóa…)

- Nếu kết thúc tư vấn người bệnh vẫn chưa hết thắc mắc thì cần mời hội chẩn tư vấn tiếp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế (2023), Quyết định số 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (căn cứ cấu trúc và định dạng).

33
2. Nguyễn Thị Dụ và cộng sự (2004), “Định hướng chung chẩn đoán và xử trí ngộ độc cấp”, Tư vấn chẩn đoán và xử trí nhanh ngộ độc cấp, tập I, Nhà xuất bản Y học, trang 9–24.

Phụ lục

Danh mục chuẩn bị để thực hiện quy trình tư vấn người bệnh ngộ độc

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	1 Bác sĩ, 1 Điều dưỡng	Người	02
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		
2.1	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	Chai	01
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Khẩu trang	Cái	02
3.2	Mũ	Cái	02
3.3	Găng tay	Đôi	02
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Giường bệnh	Cái	01
4.2	Bàn ghế	Cái	01

34

9. QUY TRÌNH LẤY DỊCH TỴ HẦU ĐỂ XÉT NGHIỆM

1. ĐẠI CƯƠNG

- Lấy dịch tỵ hầu là kỹ thuật đưa que lấy mẫu qua đường mũi đến vùng tỵ hầu để thu thập dịch tiết. Mẫu thu được dùng trong xét nghiệm phát hiện các vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt là SARS-CoV-2, cúm, RSV…

- Nguyên lý: dựa vào nguyên tắc thu mẫu đúng vị trí giải phẫu, đảm bảo vô khuẩn để tránh sai lệch kết quả.

Mục đích: giúp chẩn đoán bệnh lý đường hô hấp trên.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người nghi nhiễm bệnh hô hấp do vi khuẩn, virus.

- Chỉ lấy mẫu khi có chỉ định xét nghiệm; lựa chọn loại bệnh phẩm theo yêu cầu xét nghiệm và phòng xét nghiệm tiếp nhận.

- Sàng lọc trước phẫu thuật hoặc thủ thuật theo chỉ định và quy định hiện hành của bệnh viện, không áp dụng mặc định cho mọi người bệnh.

- Người bệnh có triệu chứng sốt, ho, đau họng, mất khứu giác, khó thở…

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người có vách ngăn mũi bị lệch nhiều.

- Người đang chảy máu cam.

- Người bệnh có tổn thương vùng mũi hoặc phẫu thuật mũi gần đây.

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh rối loạn đông máu.

- Người bệnh không hợp tác, dễ kích thích hắt hơi, nôn ói.

- Cần mang đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân để tránh lây nhiễm chéo.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Nhân lực

a) 01 Điều dưỡng hoặc kỹ thuật viên được đào tạo.

b) Nhân lực hỗ trợ: điều dưỡng phụ nếu cần cố định người bệnh.

5.2. Thuốc

Không cần thuốc (trong trường hợp thông thường).

5.3. Vật tư

- Que lấy mẫu tỵ hầu (swab vô khuẩn, đầu rayon hoặc nylon flocked).

- Ống nghiệm chứa môi trường bảo quản mẫu (VTM, UTM).

- Găng tay sạch, khẩu trang N95, kính chắn giọt bắn, áo choàng chống dịch.

- Túi zip hoặc hộp vận chuyển mẫu.

35

5.4. Trang thiết bị

- Khay dụng cụ vô khuẩn, thùng rác y tế.

- Bảng kê người bệnh.

5.5. Người bệnh

Giải thích quy trình, yêu cầu hợp tác (ngửa đầu, không di chuyển).

5.6. Hồ sơ bệnh án

Phiếu chỉ định xét nghiệm, thông tin hành chính người bệnh.

5.7. Thời gian thực hiện: 0,08–0,17 giờ/kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện: phòng lấy mẫu riêng biệt hoặc khu cách ly.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

Đối chiếu thông tin, phiếu chỉ định, nhãn bệnh phẩm.

- Xác nhận đúng người bệnh bằng ít nhất hai thông tin nhận diện, đúng chỉ định và vị trí; kiểm tra dị ứng và nguy cơ liên quan. Thực hiện bảng kiểm an toàn phù hợp, giải thích và đặt tư thế trước kỹ thuật.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Các bước thực hiện

Bước 1: chuẩn bị phương tiện, dụng cụ cần thiết.

Bước 2: rửa tay, mang phương tiện phòng hộ cá nhân đúng quy định.

Bước 3: hướng dẫn, giải thích kỹ thuật cho người bệnh.

Bước 4: yêu cầu người bệnh ngồi thẳng, ngửa nhẹ đầu.

Bước 5: đưa que lấy mẫu vào mũi (theo hướng dọc vòm khẩu cái), từ từ đến khi chạm tỵ hầu (khoảng 7 - 10 cm).

Bước 6: giữ yên que vài giây, xoay nhẹ rồi rút ra từ từ.

Bước 7: bỏ đầu que vào ống môi trường, bẻ gãy phần thân que (nếu cần), đậy kín nắp.

Bước 8: ghi nhãn đầy đủ thông tin mẫu bệnh phẩm.

Bước 9: bỏ rác y tế vào đúng nơi quy định, tháo phương tiện bảo hộ.

Bước 10: vận chuyển mẫu đến phòng xét nghiệm đúng quy định.

6.2. Ghi hồ sơ

Ghi ngày, giờ lấy mẫu, người thực hiện, dấu hiệu bất thường (nếu có).

Kết thúc quy trình

- Đánh giá lại tình trạng người bệnh và kết quả kỹ thuật; bảo đảm tư thế an toàn, thu gom dụng cụ và vệ sinh tay.

- Ghi thời gian, nội dung thực hiện, thuốc/dịch và thông số thực tế nếu có, đáp ứng và bất thường; bàn giao người bệnh và kế hoạch theo dõi cho nhân viên hoặc bộ phận tiếp theo khi cần.

36

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Hắt hơi, nôn, chảy máu mũi → ngừng thủ thuật, trấn an người bệnh.

7.2. Sau khi thực hiện

Quan sát phản ứng người bệnh (mệt, choáng, khó chịu...).

7.3. Biến chứng muộn

Hiếm gặp, nhưng cần theo dõi nếu có triệu chứng kéo dài (đau họng, chảy máu mũi...).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. CDC (2024). Interim Guidelines for Collecting and Handling of Clinical Specimens for COVID-19 Testing. Tham khảo kỹ thuật lấy mẫu tỵ hầu; xét nghiệm khác thực hiện theo hướng dẫn bộ xét nghiệm. https://www.cdc.gov/covid/hcp/clinical-care/clinical-specimen-guidelines.html

2. Bộ Y tế (2021), Quyết định về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19, Hà Nội.

3. WHO Guidelines on COVID-19 Laboratory Testing Procedures.

Danh mục

chuẩn bị thực hiện quy trình lấy dịch tỵ hầu để xét nghiệm

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng/kỹ thuật viên thực hiện	Người	1
1.2	Nhân lực hỗ trợ cố định người bệnh (nếu cần)	Người	1
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		
2.1	Không dùng thuốc thường quy		
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Khẩu trang, mũ	Cái	02
3.2	Găng tay	Đôi	02
3.3	Que lấy mẫu tỵ hầu vô khuẩn phù hợp xét nghiệm	Cái	Theo chỉ định xét nghiệm
3.4	Ống chứa mẫu và môi trường vận chuyển phù hợp bộ xét nghiệm	Ống	Theo chỉ định xét nghiệm
3.5	Kính bảo vệ mắt hoặc tấm chắn giọt bắn; áo choàng theo nguy cơ lây nhiễm	Bộ	Theo quy định kiểm soát nhiễm khuẩn

37

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
3.6	Nhãn nhận diện, túi kín và bao bì vận chuyển bệnh phẩm	Bộ	Theo số mẫu
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Ghế hoặc giường phù hợp tư thế lấy mẫu	Cái	01

38

10. QUY TRÌNH ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên là kỹ thuật sử dụng một ống thông nhỏ đưa vào lòng tĩnh mạch ngoại biên (tay, chân) để truyền dịch, truyền thuốc hoặc lấy máu.

- Nguyên lý: ống catheter được đưa vào lòng tĩnh mạch dưới sự hỗ trợ của kim dẫn đường. Sau khi catheter vào đúng vị trí, kim được rút ra, để lại catheter trong lòng mạch.

- Mục đích:

+ Đảm bảo đường truyền ổn định, lâu dài hơn so với kim luồn thông thường.

+ Giảm số lần chọc kim khi điều trị kéo dài.

+ Hạn chế tổn thương tĩnh mạch do truyền thuốc kích ứng.

2. CHỈ ĐỊNH

Khi cần truyền dịch, lấy máu xét nghiệm và thực hiện tiêm, truyền thuốc.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Rối loạn đông máu (chống chỉ định tương đối).

- Huyết khối tĩnh mạch.

- Giãn tĩnh mạch ngoại biên.

- Sốt xuất huyết.

4. THẬN TRỌNG

- Người có rối loạn đông máu.

- Người già, trẻ nhỏ, người bệnh có da mỏng.

- Luôn kiểm tra vị trí catheter sau khi đặt và trong quá trình sử dụng.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

- 01 điều dưỡng.

- Trang bị mũ, khẩu trang.

- Vệ sinh bàn tay, đi găng tay vô trùng.

5.2. Thuốc: Natri clorid 0,9% 500 mL.

5.3. Vật tư

- Gòn, gạc che kim.

- Catheter ngoại biên các cỡ, bộ dây truyền dịch.

- Găng tay sạch.

- băng keo.

39

- Chai sát khuẩn tay nhanh.

- Dây garo.

5.4. Trang thiết bị

- Bộ dụng cụ tiêm truyền vô khuẩn.

- Trụ treo.

5.5. Người bệnh

- Giải thích cho Người bệnh và người nhà kỹ thuật sắp làm.

- Đo mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở.

- Tư thế người thoải mái.

- Vị trí đặt: chọn tĩnh mạch.

5.6. Hồ sơ, bệnh án: theo quy định Bộ Y tế.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: ghi thời gian thực tế bằng giờ; định mức thời gian do bệnh viện xác nhận theo phương pháp và tình trạng người bệnh.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ bệnh án

- Kiểm tra 5 đúng.

- Thực hiện bảng kiểm an toàn kỹ thuật.

- Xác nhận đúng người bệnh bằng ít nhất hai thông tin nhận diện, đúng chỉ định và vị trí; kiểm tra dị ứng và nguy cơ liên quan. Thực hiện bảng kiểm an toàn phù hợp, giải thích và đặt tư thế trước kỹ thuật.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: kiểm tra chai dịch natrichlorua 0,9%, cắm dây truyền vào chai, xả dịch truyền và khoá lại. Bộc lộ vùng cần đặt catheter, chọn tĩnh mạch.

- Bước 2: đi găng tay sạch, buộc dây garo trên vùng cần đặt 3 - 5 cm.

- Bước 3: sát khuẩn vị trí cần đặt từ trong ra ngoài theo hình xoáy ốc 2 lần, điều dưỡng sát khuẩn tay.

- Bước 4: lắp kim có catheter. Một tay căng da, một tay cầm catheter đâm kim chếch 30 độ so với mặt da vào tĩnh mạch thấy máu trào ra. Rút từ từ nòng kim ra khỏi catheter, lắp dây truyền đã chuẩn bị trước vào đốc catheter.Tháo dây garo, mở khoá cho dịch chảy.

- Bước 5: cố định catheter và dây truyền, che catheter bằng gạc vô khuẩn.

- Bước 6: điều chỉnh tốc độ truyền theo chỉ định.

- Bước 7: giúp người bệnh về tư thế thoải mái, theo dõi và phát hiện tai biến, dặn người bệnh những điều cần thiết.

- Bước 8: thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.

- Bước 9: ghi bệnh án: ghi phiếu chăm sóc, phiếu truyền dịch.

40

Kết thúc quy trình

- Đánh giá lại tình trạng người bệnh và kết quả kỹ thuật; bảo đảm tư thế an toàn, thu gom dụng cụ và vệ sinh tay.

- Ghi thời gian, nội dung thực hiện, thuốc/dịch và thông số thực tế nếu có, đáp ứng và bất thường; bàn giao người bệnh và kế hoạch theo dõi cho nhân viên hoặc bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

- Theo dõi toàn trạng người bệnh trong quá trình tiến hành kỹ thuật (sắc mặt, mạch, SpO_2) để phát hiện tai biến.

- Theo dõi nơi đặt catheter hàng ngày, theo dõi chảy máu, nhiễm khuẩn, thay băng.

- Nhiễm khuẩn nơi đặt, nhiễm khuẩn huyết: rút catheter, cấy đầu catheter.

- Tắc catheter: thông truyền, nếu tắc quá lâu không thông được phải rút catheter ra.

- Đứt catheter (hiếm gặp), tuột catheter: đặt lại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế (2012), Quyết định về việc phê duyệt các hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn, Hà Nội.

2. Bộ Y tế (2023), Quyết định số 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (căn cứ cấu trúc và định dạng).

3. CDC. Summary of Recommendations, Intravascular Catheter Related Infections. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/intravascular-catheter-related-infections/summary-recommendations.html

Phụ lục

Danh mục chuẩn bị để thực hiện quy trình kỹ thuật đặt catheter ngoại biên

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng đã được đào tạo, có năng lực và được phân công thực hiện kỹ thuật	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		
2.1	Natri clorua 0,9% 500 mL	Chai	01
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Gòn, gạc che kim	Bọc	01
3.2	băng keo	Cuộn	01
3.3	Catheter ngoại vi các cỡ	Cái	01
3.4	Dây truyền dịch, Dây garo	Sợi	01

41

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
3.5	Găng tay sạch	Đôi	01
3.6	Chai sát khuẩn tay nhanh	Chai	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Trụ treo	Cái	01

42

11. QUY TRÌNH CHĂM SÓC CATHETER TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: chăm sóc catheter tĩnh mạch ngoại biên là các thao tác điều dưỡng nhằm duy trì sự thông suốt của đường truyền, phòng ngừa nhiễm khuẩn, phát hiện sớm và xử trí các tai biến, biến chứng liên quan đến catheter.

- Nguyên lý: duy trì kỹ thuật vô khuẩn khi chăm sóc; đánh giá vị trí đặt và nhu cầu duy trì catheter, thay băng khi ẩm, bẩn, bong hoặc theo loại băng và quy định của bệnh viện.

- Mục đích:

+ Giữ catheter luôn thông suốt và an toàn.

+ Phòng tránh nhiễm khuẩn và biến chứng.

+ Đảm bảo hiệu quả điều trị và an toàn cho người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

- Áp dụng cho tất cả người bệnh có đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên.

- Thời gian thực hiện: khi gạc che thấm dịch, máu hoặc thấy viêm đỏ, chảy máu quanh chân catheter.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định tuyệt đối với chăm sóc catheter. Không tháo băng còn nguyên vẹn chỉ để kiểm tra thường quy nếu không có dấu hiệu bất thường; thay ngay khi băng ẩm, bẩn hoặc bong, không chờ đủ 72 giờ.

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh có nguy cơ cao nhiễm khuẩn: suy giảm miễn dịch, tiểu đường, trẻ sơ sinh, người già.

- Catheter để lâu ngày (trên 72 - 96 giờ) cần đánh giá lại chỉ định duy trì.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện: điều dưỡng: rửa tay, đội mũ , đeo khẩu trang.

5.2. Thuốc:

- Nước muối Natri clorid 0,9%.

- povidone-iodine 10%.

5.3. Vật tư

- Gòn, gạc che kim.

- Dụng cụ chăm sóc hoặc thay băng vô khuẩn.

- băng keo.

- Túi đựng đồ bẩn.

- Dung dịch rửa tay nhanh.

- Găng tay sạch.

43

5.4. Trang thiết bị: không có.

5.5. Người bệnh:

- Thông báo, giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh kỹ thuật sắp làm.

- Đặt người bệnh ở tư thế thích hợp.

5.6. Hồ sơ bệnh án: theo quy định của Bộ Y tế.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: dự kiến khoảng 0,08–0,17 giờ

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ : thực hiện bảng kiểm an toàn kỹ thuật.

- Xác nhận đúng người bệnh bằng ít nhất hai thông tin nhận diện, đúng chỉ định và vị trí; kiểm tra dị ứng và nguy cơ liên quan. Thực hiện bảng kiểm an toàn phù hợp, giải thích và đặt tư thế trước kỹ thuật.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: mở gói dụng cụ, đổ dung dịch nước muối 0,9% vào bát kền.

- Bước 2: đeo găng sạch

- Bước 3: đặt khay quả đậu ở vị trí thích hợp.

- Bước 4: tháo bỏ gạc cũ.

- Bước 5: đánh giá chân catheter, mức độ viêm chân catheter hay không.

- Bước 6: vệ sinh khi có bẩn nhìn thấy, sử dụng dung dịch sát khuẩn được bệnh viện phê duyệt, đúng nồng độ và thời gian tiếp xúc; để khô tự nhiên. Không tự pha loãng povidone-iodine hoặc chạm lại vị trí đã sát khuẩn.

- Bước 7: đặt gạc che catheter, băng cố định bằng băng keo.

- Bước 8: tháo bỏ găng bẩn.

- Bước 9: đặt người bệnh về tư thế thoải mái.

- Bước 10: thu dọn dụng cụ.

- Bước 11: rửa tay.

- Bước 12: ghi phiếu chăm sóc: thời gian thực hiện, người thực hiện.

Kết thúc quy trình

- Đánh giá lại tình trạng người bệnh và kết quả kỹ thuật; bảo đảm tư thế an toàn, thu gom dụng cụ và vệ sinh tay.

- Ghi thời gian, nội dung thực hiện, thuốc/dịch và thông số thực tế nếu có, đáp ứng và bất thường; bàn giao người bệnh và kế hoạch theo dõi cho nhân viên hoặc bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

- Theo dõi chân catheter có thấm dịch, máu thì thay ngay. Theo dõi đánh giá chảy máu chỗ, nhiễm trùng tại chân catheter.

- Theo dõi vị trí cố định: mức độ lỏng, tuột của catheter, gập gãy catheter.

44

- Tuột catheter do cố định lỏng, người bệnh có nhiều mồ hôi người bệnh giãy giụa nhiều.

- Nghi viêm tĩnh mạch, nhiễm khuẩn hoặc catheter không hoạt động: ngừng sử dụng, báo bác sĩ, xử trí/rút catheter ngoại biên theo quy trình và thiết lập đường truyền khác khi có chỉ định.

- Tắc catheter: ngừng sử dụng, kiểm tra dây và vị trí, báo người phụ trách; không bơm mạnh hoặc đẩy cục máu đông vào mạch.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế (2012), Quyết định về việc phê duyệt các hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn, Hà Nội.

2. Bộ Y tế (2023), Quyết định số 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (căn cứ cấu trúc và định dạng).

3. CDC. Summary of Recommendations, Intravascular Catheter Related Infections. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/intravascular-catheter-related-infections/summary-recommendations.html

Phụ lục

Danh mục chuẩn bị để thực hiện

quy trình chăm sóc catheter tĩnh mạch ngoại biên

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng đã được đào tạo, có năng lực và được phân công thực hiện kỹ thuật	Người	01
2	thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		
2.1	Natri clorua 0,9% 100 mL	Chai	01
2.2	povidone-iodine 10%	Chai	01
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Gòn, gạc che kim	Bọc	01
3.2	Bộ chăm sóc hoặc thay băng vô khuẩn	Bộ	01
3.3	băng keo	Cuộn	01
3.4	Găng tay sạch	Đôi	01
3.5	Sát khuẩn tay nhanh	Chai	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Không có		

45

12. QUY TRÌNH CHĂM SÓC CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: chăm sóc catheter tĩnh mạch trung tâm là các thao tác điều dưỡng nhằm đảm bảo catheter luôn thông suốt, vô khuẩn và phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết, viêm tĩnh mạch và các biến chứng liên quan đến catheter.

- Nguyên lý: giữ vô khuẩn tuyệt đối trong quá trình chăm sóc và sử dụng catheter; kiểm tra định kỳ để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

- Mục đích:

+ Duy trì chức năng catheter trung tâm ổn định.

+ Phòng tránh nhiễm khuẩn và tắc nghẽn catheter.

+ Tăng hiệu quả điều trị và đảm bảo an toàn người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

- Áp dụng cho tất cả người bệnh có đặt catheter tĩnh mạch trung tâm.

- Thời gian thực hiện: khi băng thấm dịch, máu, hoặc qua opside thấy viêm đỏ, chảy máu quanh chân catheter.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định tuyệt đối với chăm sóc catheter. Thay băng ngay khi ẩm, bẩn hoặc bong. Với catheter trung tâm ngắn hạn: băng gạc thay mỗi 2 ngày, băng trong suốt ít nhất mỗi 7 ngày; điều chỉnh cho trẻ em, loại catheter và hướng dẫn sản phẩm theo quy định bệnh viện.

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh có nguy cơ cao nhiễm khuẩn: suy giảm miễn dịch, hóa trị liệu, đang sốt kéo dài.

- Tránh làm bong catheter hoặc làm nhiễm khuẩn trong khi chăm sóc.

- Thực hiện vô khuẩn tuyệt đối.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện: điều dưỡng: rửa tay, đội mũ , đeo khẩu trang.

5.2. Thuốc:

- Natri clorid 0,9%.

- povidone-iodine 10%.

5.3. Vật tư

- Gòn, gạc.

- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

- Dụng cụ thủ thuật.

- Dụng cụ chăm sóc hoặc thay băng vô khuẩn.

- Băng trong suốt vô khuẩn.

46

5.4. Trang thiết bị

5.5. Người bệnh:

- Thông báo, giải thích cho người bệnh (nếu người bệnh tỉnh).

- Đặt người bệnh ở tư thế thích hợp: đầu cao 30 độ, nghiêng mặt về bên đối diện đặt catheter.

5.6. Hồ sơ bệnh án: theo quy định Bộ Y tế.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: dự kiến khoảng 0,17–0,25 giờ.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra đúng người bệnh, đúng thời gian, đúng chẩn đoán.

- Xác nhận đúng người bệnh bằng ít nhất hai thông tin nhận diện, đúng chỉ định và vị trí; kiểm tra dị ứng và nguy cơ liên quan. Thực hiện bảng kiểm an toàn phù hợp, giải thích và đặt tư thế trước kỹ thuật.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: mở gói dụng cụ, đổ dung dịch nước muối 0,9% vào chén chun.

- Bước 2: đi găng sạch.

- Bước 3: đặt khay quả đậu ở vị trí thích hợp.

- Bước 4: tháo bỏ băng cũ bằng găng sạch, tránh kéo tuột catheter.

- Bước 5: đánh giá chân catheter và vùng da; nhận diện đỏ, đau, tiết dịch hoặc dấu hiệu nhiễm khuẩn.

- Bước 6: tháo găng bẩn, vệ sinh tay; chuẩn bị thao tác vô khuẩn.

- Bước 7: đi găng vô khuẩn.

- Bước 8: sát khuẩn da bằng chlorhexidine trên 0,5% trong cồn nếu phù hợp; khi chống chỉ định dùng dung dịch thay thế được phê duyệt. Tuân thủ hướng dẫn sản phẩm, để khô; lưu ý riêng đối với trẻ nhỏ, không tự pha loãng.

- Bước 9: đặt gạc hoặc opside vào chân catheter, băng lại bằng băng keo.

- Bước 10: tháo bỏ găng bẩn.

- Bước 11: đặt người bệnh về tư thế thoải mái.

- Bước 12: thu dọn dụng cụ.

- Bước 13: rửa tay.

- Bước 14: ghi phiếu chăm sóc: ghi diễn biến, thời gian thực hiện, người thực hiện.

Kết thúc quy trình

- Đánh giá lại tình trạng người bệnh và kết quả kỹ thuật; bảo đảm tư thế an toàn, thu gom dụng cụ và vệ sinh tay.

47
- Ghi thời gian, nội dung thực hiện, thuốc/dịch và thông số thực tế nếu có, đáp ứng và bất thường; bàn giao người bệnh và kế hoạch theo dõi cho nhân viên hoặc bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

- Theo dõi chân catheter có thấm dịch, máu hoặc opside bị bong thì thay ngay.

- Theo dõi đánh giá chảy máu chỗ chọc, nhiễm trùng tại chân catheter.

- Theo dõi vị trí cố định: mức độ lỏng, tuột của catheter, gập gãy catheter.

- Tuột catheter do cố định lỏng, người bệnh có nhiều mồ hôi người bệnh giãy giụa nhiều.

+ Theo dõi thường xuyên vị trí cố định, băng thấm dịch, mồ hôi.

+ Ngừng sử dụng nếu nghi catheter di lệch, cố định tạm và báo bác sĩ; không đẩy catheter đã tuột trở lại. Việc rút/thay catheter trung tâm thực hiện theo chỉ định và thẩm quyền.

- Nghi nhiễm khuẩn tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn huyết: báo bác sĩ, đánh giá toàn trạng; lấy mẫu và quyết định duy trì/rút catheter theo chỉ định, không chỉ thay băng để xử trí.

- Tắc catheter: kiểm tra nguyên nhân cơ học, ngừng sử dụng và báo bác sĩ; không cố bơm hoặc đẩy cục máu đông vào lòng mạch.

- Báo bác sĩ biết khi có viêm chân catheter, phụ bác sĩ rút catheter.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế (2012), Quyết định về việc phê duyệt các hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn, Hà Nội.

2. Bộ Y tế (2014), Quyết định về việc hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành hồi sức cấp cứu và chống độc, Hà Nội.

3. Bộ Y tế (2023), Quyết định số 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (căn cứ cấu trúc và định dạng).

4. CDC. Guidelines for Prevention of Intravascular Catheter Related Infections, 2011. https://www.cdc.gov/infection-control/media/pdfs/Guideline-BSI-H.pdf

Phụ lục

Danh mục chuẩn bị để thực hiện quy trình chăm sóc catheter tĩnh mạch trung tâm

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng đã được đào tạo, có năng lực và được phân công thực hiện kỹ thuật	Người	01
2	thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		

48

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
2.1	Natri clorua 0,9% 100 mL	Chai	01
2.2	Dung dịch sát khuẩn da: chlorhexidine >0,5% trong cồn nếu phù hợp; dung dịch thay thế khi chống chỉ định	Theo chế phẩm	Theo hướng dẫn sản phẩm
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Gòn, gạc	Gói	01
3.2	băng keo	Cuộn	01
3.3	Bộ thay băng vô khuẩn	Bộ	01
3.4	Băng trong suốt vô khuẩn	Miếng	01
3.5	Găng tay sạch	Đôi	01
3.6	Găng tay vô khuẩn	Đôi	01
3.7	Sát khuẩn tay nhanh	Chai	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Không có		

49

13. QUY TRÌNH ĐẶT ỐNG THÔNG DẠ DÀY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: đặt ống thông dạ dày là kỹ thuật đưa ống mềm qua mũi hoặc miệng, qua thực quản vào dạ dày để hút dịch tiêu hóa, bơm thuốc hoặc nuôi dưỡng người bệnh.

- Nguyên lý: dựa trên đặc điểm giải phẫu của đường tiêu hóa trên, kỹ thuật phải bảo đảm vô khuẩn, nhẹ nhàng, đúng vị trí nhằm hạn chế tai biến như sặc, thủng, sai vị trí.

- Mục đích:

+ Hút dịch tiêu hóa hoặc chất độc trong trường hợp ngộ độc.

+ Bơm thuốc, nuôi ăn qua đường tiêu hóa khi người bệnh không thể ăn qua miệng.

+ Chuẩn bị cho một số phẫu thuật hoặc thủ thuật.

2. CHỈ ĐỊNH

- Để nuôi dưỡng: đối với những người bệnh hôn mê, co giật, trẻ đẻ non (phản xạ mút, nuốt kém), dị dạng đường tiêu hóa nặng hoặc ăn bằng đường miệng có nguy cơ suy hô hấp hoặc ngạt.

- Hút/rửa dạ dày trong một số trường hợp ngộ độc khi bác sĩ chỉ định sau đánh giá lợi ích–nguy cơ; không áp dụng thường quy cho mọi ngộ độc hoặc mọi xuất huyết tiêu hóa.

- Để dẫn lưu dịch dạ dày, giúp giảm áp lực trong ống tiêu hóa: trong các trường hợp tắc ruột, liệt ruột cơ năng (viêm tụy cấp…) hoặc sau phẫu thuật đường tiêu hóa.

- Theo dõi tình trạng chảy máu dạ dày, sự tái phát của chảy máu dạ dày.

- Lấy dịch dạ dày làm xét nghiệm.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tổn thương ở thực quản: u, dò, bỏng thực quản dạ dày do acid hoặc kiềm mạnh, teo thực quản.

- Nghi thủng dạ dày.

- Áp xe thành họng.

- Tổn thương vùng hàm mặt.

- Bệnh ở thực quản: co thắt, chít hẹp, phình tĩnh mạch, động mạch thực quản.

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh suy giảm ý thức, dễ sặc: cần hút đờm trước, chuẩn bị dụng cụ cấp cứu.

- Trẻ em, người già, người bệnh tâm thần cần theo dõi sát trong và sau khi đặt.

- Xác nhận vị trí trước sử dụng bằng pH dịch hút trong ngưỡng an toàn theo quy trình được phê duyệt hoặc X-quang do người có thẩm quyền đọc. Không dùng nghe khí hoặc thử sủi bọt để xác nhận vị trí.

50

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện: điều dưỡng.

5.2. Thuốc: không dùng thường quy; thuốc hỗ trợ nếu có phải theo chỉ định.

5.3. Vật tư

- Ống thông phù hợp tuổi, mục đích dẫn lưu/nuôi dưỡng và hướng dẫn thiết bị; ghi cỡ bằng Fr. Không dùng một cỡ chung hoặc quy đổi sai Fr sang đường kính trong.

- Găng tay sạch: 2 đôi.

- Gel bôi trơn tan trong nước, tương thích ống thông; không dùng vaselin hoặc thuốc mỡ kháng sinh để bôi trơn ống.

- Gạc vô trùng.

- băng keo.

- Túi dẫn lưu ống thông dạ dày.

- Ống nghe, huyết áp.

- Bơm tiêm 50 mL, máy hút (nếu có).

- Ống nghiệm, giá đựng ống nghiệm (nếu có).

- Hộp thuốc chống sốc.

- Chén chun.

5.4. Trang thiết bị: phương tiện hút và hỗ trợ hô hấp khi cần; giấy thử pH phù hợp để kiểm tra dịch hút. X-quang theo chỉ định khi không xác nhận được vị trí an toàn.

5.5. Người bệnh

- Động viên, giải thích cho người bệnh thủ thuật sắp làm để người bệnh yên tâm và hợp tác. Nếu người bệnh hôn mê phải giải thích cho người nhà.

- Tháo răng giả (nếu có).

- Người bệnh giảm ý thức hoặc không bảo vệ được đường thở: bác sĩ đánh giá và kiểm soát đường thở trước khi thực hiện; không tự quyết định đặt nội khí quản chỉ vì có hôn mê.

5.6. Hồ sơ bệnh án: theo quy định của Bộ Y tế.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: tùy vào từng trường hợp cụ thể.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: tại phòng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định.

- Xác nhận đúng người bệnh bằng ít nhất hai thông tin nhận diện, đúng chỉ định và vị trí; kiểm tra dị ứng và nguy cơ liên quan. Thực hiện bảng kiểm an toàn phù hợp, giải thích và đặt tư thế trước kỹ thuật.

51

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: người bệnh tỉnh ở tư thế nửa nằm nửa ngồi nếu không chống chỉ định. Người giảm ý thức được bác sĩ đánh giá đường thở và chọn tư thế phù hợp; không mặc định đầu thấp.

- Bước 2: đo chiều dài đặt theo đường đưa ống, tuổi và hướng dẫn loại ống; đánh dấu. Độ dài đo ngoài chỉ là ước tính, không thay xác nhận vị trí trong dạ dày.

- Bước 3: bôi gel tan trong nước tương thích thiết bị vào đầu ống theo hướng dẫn sản phẩm.

- Bước 4: chọn đường mũi hoặc miệng theo chỉ định và tình trạng giải phẫu; đưa ống nhẹ nhàng, không cố đẩy khi gặp cản trở. Người giảm ý thức thực hiện dưới giám sát và bảo vệ đường thở phù hợp.

- Bước 5: nhẹ nhàng đưa ống vào miệng, sát má, tránh vòm họng và lưỡi gà, động viên người bệnh nuốt, trong khi đó điều dưỡng từ từ đẩy ống và đến vạch đánh dấu chạm tới cung răng thì dừng lại. Nếu người bệnh có sặc, ho dữ dội, tái mặt, tím môi thì rút ra và đưa lại.

- Bước 6: xác nhận vị trí trước bơm bất kỳ dịch, thức ăn hoặc thuốc. Dịch hút có pH 1–5,5 là một phương pháp xác nhận theo quy trình bệnh viện; nếu không hút được, pH ngoài ngưỡng hoặc có nghi ngờ, không sử dụng và báo bác sĩ để xác nhận bằng X-quang. Không nghe khí hoặc nhúng đầu ống vào nước.

- Bước 7: cố định ống thông dạ dày bằng băng keo.

- Bước 8: đậy ống thông dạ dày.

- Bước 9: ghi hồ sơ bệnh án: ghi vào phiếu chăm sóc diễn biến của người bệnh, thời gian thực hiện, người thực hiện.

Kết thúc quy trình

- Đánh giá lại tình trạng người bệnh và kết quả kỹ thuật; bảo đảm tư thế an toàn, thu gom dụng cụ và vệ sinh tay.

- Ghi thời gian, nội dung thực hiện, thuốc/dịch và thông số thực tế nếu có, đáp ứng và bất thường; bàn giao người bệnh và kế hoạch theo dõi cho nhân viên hoặc bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

- Toàn trạng: mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ.

- Phản xạ ho sặc tránh hít phải dịch.

- Nôn mửa gây sặc dịch dạ dày: máy hút, đặt nội khí quản.

- Nhịp tim chậm, ngất do kích thích dây X: hồi sức cấp cứu.

- Đặt nhầm vào khí quản: khi thấy người bệnh ho, sặc, tím môi phải rút ống thông ngay.

- Tổn thương vùng mặt.

52

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế (2023), Quyết định số 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (căn cứ cấu trúc và định dạng).

2. Trần Thị Thuận (2007), Điều dưỡng cơ bản II, trang 72 - 81.

3. NHS England. Medical device safety, nasogastric tube placement standards. https://www.england.nhs.uk/patient-safety/patient-safety-insight/patient-safety-alerts/enduring-standards/standards-that-remain-valid/medical-device-safety/

Phụ lục

Danh mục chuẩn bị để thực hiện quy trình đặt ống thông dạ dày

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng đã được đào tạo, có năng lực và được phân công thực hiện kỹ thuật	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		
2.1	Gel bôi trơn vô khuẩn tan trong nước	Tuýp	01
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Ống thông dạ dày phù hợp mục đích, tuổi và loại thiết bị; ghi cỡ bằng Fr	Cái	01
3.2	Bơm tiêm dùng cho ống thông, đầu nối tương thích	Cái	01
3.3	Ống nghiệm, giá đựng ống nghiệm, (nếu có)	Ống	01
3.4	Gạc vô trùng	Bọc	01
3.5	Găng tay sạch	Đôi	02
3.6	băng keo	Cuộn	01
3.7	Chén chun	Cái	01
3.8	Hộp thuốc chống sốc	Hộp	01
3.9	Giấy thử pH phù hợp kiểm tra dịch hút dạ dày	Miếng	Theo số lần kiểm tra
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Huyết áp, ống nghe	Bộ	01

53

14. QUY TRÌNH NUÔI DƯỠNG QUA ỐNG THÔNG DẠ DÀY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày là kỹ thuật đưa thức ăn, dung dịch nuôi dưỡng hoặc thuốc vào dạ dày thông qua ống thông đã được đặt sẵn, nhằm cung cấp dinh dưỡng cho người bệnh không thể ăn bằng miệng.

- Nguyên lý: dựa trên cơ chế hấp thu của dạ dày - ruột, kỹ thuật cần đảm bảo lượng, tốc độ và thành phần dinh dưỡng phù hợp, đồng thời ngăn ngừa sặc, nhiễm trùng, tắc ống.

- Mục đích:

+ Cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho người bệnh.

+ Hỗ trợ điều trị và phục hồi sức khỏe.

+ Đảm bảo an toàn trong quá trình nuôi ăn không qua đường miệng.

2. CHỈ ĐỊNH

2.1. Người bệnh không thể ăn được

- Người bệnh sau đặt nội khí quản, mở khí quản, Người bệnh đang thở máy.

- Người bệnh mất hoặc giảm khả năng bảo vệ đường thở, rối loạn nuốt, liệt thần kinh hầu họng do mọi nguyên nhân, hôn mê, co giật, tai biến mạch não.

- Người bệnh có bệnh lý đường tiêu hóa: liệt dạ dày, u thực quản chưa gây tắc nghẽn toàn bộ, tổn thương miệng.

2.2. Người bệnh tự ăn ít, cần được cung cấp thêm dinh dưỡng

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Xuất huyết tiêu hóa cấp nặng.

- Các tổn thương loét ăn mòn thực quản dạ dày chưa kiểm soát được.

- Tắc ruột, liệt ruột dạ dày.

- Thể tích dịch tồn dư quá lớn (tuân thủ đánh giá thể tích dịch tồn dư).

- Các chỉ định trước, sau tiểu phẫu phẫu thuật, nội soi....

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh có nguy cơ hít sặc (rối loạn ý thức, liệt cơ hầu họng...).

- Người bệnh có tiền sử trào ngược dạ dày thực quản.

- Đánh giá dung nạp nuôi dưỡng theo tình trạng lâm sàng và phác đồ dinh dưỡng của bệnh viện; không dùng một ngưỡng dịch tồn dư chung để tự ngừng nuôi dưỡng hoặc chuyển sang đường tĩnh mạch.

- Luôn kiểm tra vị trí ống trước khi bơm dung dịch.

54

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện: điều dưỡng đã được đào tạo chuyên khoa Hồi sức cấp cứu.

5.2. Thuốc: không có.

5.3. Vật tư

- Bơm tiêm 50 mL: 01 cái.
- băng keo.
- Gạc vô trùng.
- Găng sạch : 01 đôi.
- Ống nghe.
- Cốc sạch đựng thức ăn chia độ.
- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh.
- Xà phòng diệt khuẩn.
- Khăn sạch.
- Thức ăn cho người bệnh theo chỉ định (chế độ bệnh lý hoặc sữa).

5.4. Trang thiết bị

Máy theo dõi nối với cáp điện tim, cáp đo SpO_2, cáp đo huyết áp.

5.5. Người bệnh

- Thông báo, giải thích cho người bệnh hoặc gia đình về kỹ thuật sắp làm.
- Đặt người bệnh ở tư thế đầu cao theo phác đồ dinh dưỡng và khả năng dung nạp; tránh tư thế nằm phẳng khi nuôi dưỡng nếu không có chống chỉ định.

5.6. Hồ sơ bệnh án: theo quy định của Bộ Y tế.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: phụ thuộc phương pháp, thể tích và tốc độ theo kế hoạch dinh dưỡng; ghi thời gian thực tế bằng giờ.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra đúng người bệnh, đúng chỉ định, đúng chẩn đoán.

- Xác nhận đúng người bệnh bằng ít nhất hai thông tin nhận diện, đúng chỉ định và vị trí; kiểm tra dị ứng và nguy cơ liên quan. Thực hiện bảng kiểm an toàn phù hợp, giải thích và đặt tư thế trước kỹ thuật.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Các bước trước khi cho ăn qua ống thông

- Bước 1: điều dưỡng rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn đúng quy trình kỹ thuật.
- Bước 2: điều dưỡng đội mũ, đeo khẩu trang, đưa dụng cụ đến giường người bệnh.
- Bước 3: đặt Người bệnh ở tư thế đầu cao nghiêng sang một bên, trải khăn trước ngực.

55
- Bước 4: Chuẩn bị thức ăn theo chỉ định của bác sĩ (sữa, súp bơm qua ống thông.)

6.2. Đánh giá dịch tồn dư dạ dày

- Việc theo dõi dịch tồn dư áp dụng theo phác đồ dinh dưỡng đã được phê duyệt, loại ống và chỉ định; không coi hút tồn dư là bắt buộc cho mọi người bệnh.

- Tần suất theo dõi theo chỉ định và diễn biến lâm sàng; kết hợp nôn, chướng bụng, đau bụng, trào ngược, tình trạng hô hấp và lượng dinh dưỡng thực nhận.

- Các phương pháp cho ăn qua ống thông dạ dày: 2 phương pháp cơ bản.

+ Cho ăn liên tục: dùng hệ thống phù hợp, thực hiện thể tích, tốc độ và thời gian nghỉ theo kế hoạch dinh dưỡng được chỉ định.

+ Cho ăn ngắt quãng: thực hiện lượng mỗi lần, thời gian và số lần theo kế hoạch dinh dưỡng; theo dõi dung nạp trong và sau mỗi lần.

- Quy trình đối với bữa đầu sau đặt ống thông dạ dày hoặc với các người bệnh cho ăn lại (viêm tụy cấp sau thời gian nhịn ăn):

+ Bước 1: điều dưỡng rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn đúng quy trình kỹ thuật.

+ Bước 2: điều dưỡng đội mũ, đeo khẩu trang, đưa dụng cụ đến giường người bệnh.

+ Bước 3: đặt người bệnh ở tư thế đầu cao nghiêng sang một bên, trải khăn trước ngực.

+ Bước 4: chuẩn bị thức ăn theo chỉ định của bác sĩ (sữa, súp bơm qua ống thông…).

+ Bước 5: kiểm tra vị trí ống thông dạ dày trước khi cho ăn.

+ Bước 6: duy trì tư thế đầu cao theo phác đồ dinh dưỡng; kiểm tra dung nạp và nguy cơ hít sặc.

+ Bước 7: nối ống thông dạ dày với túi đựng thức ăn lỏng, sau đó điều chỉnh giọt.

+ Bước 8: cho phù hợp với lượng calo. Hoặc có thể sử dụng bơm tiêm 50 mL để bơm trực tiếp thức ăn lỏng vào ống thông dạ dày.

+ Bước 9: bơm nước sôi để nguội hoặc nước vô khuẩn để làm sạch ống thông.

+ Bước 10: ghi hồ sơ bệnh án: ghi phiếu chăm sóc, diễn biến, thời gian thực hiện, người thực hiện.

Thể tích, thành phần, tốc độ khởi đầu và tăng tốc độ theo chỉ định dinh dưỡng cá thể hóa. Khi nghi không dung nạp, tạm ngừng nếu cần và báo bác sĩ; không tự bỏ dịch tồn dư hoặc chuyển nuôi dưỡng tĩnh mạch theo ngưỡng 100 mL.

- Quy trình đối với người bệnh ăn qua ống thông dạ dày thường quy:

+ Bước 1: điều dưỡng rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn đúng quy trình kỹ thuật.

+ Bước 2: điều dưỡng đội mũ, đeo khẩu trang, đưa dụng cụ đến giường người bệnh.

+ Bước 3: đặt người bệnh ở tư thế đầu cao nghiêng sang một bên, trải khăn trước ngực.

+ Bước 4: chuẩn bị thức ăn theo chỉ định của bác sĩ (sữa, súp bơm qua ống thông…)

+ Bước 5: kiểm tra vị trí ống thông dạ dày trước khi cho ăn.

56
+ Bước 6: duy trì tư thế đầu cao theo phác đồ dinh dưỡng; kiểm tra dung nạp và nguy cơ hít sặc.

+ Bước 7: nối ống thông dạ dày với túi đựng thức ăn lỏng, sau đó điều chỉnh giọt.

+ Bước 8: cho phù hợp với lượng calo. Hoặc có thể sử dụng bơm tiêm 50 mL để bơm trực tiếp thức ăn lỏng vào ống thông dạ dày.

+ Bước 9: bơm nước sôi để nguội hoặc nước vô khuẩn để làm sạch ống thông.

+ Bước 10: ghi hồ sơ bệnh án: ghi diễn biến, thời gian, người thực hiện.

Lượng thức ăn và tốc độ thực hiện theo chỉ định; ghi lượng được chỉ định và lượng thực nhận, không áp dụng 240 mL/3 giờ hoặc 80 mL/giờ cho tất cả người bệnh.

Nếu nôn, chướng bụng, trào ngược hoặc nghi hít sặc: dừng nuôi dưỡng, đánh giá hô hấp, kiểm tra vị trí ống và báo bác sĩ. Xử trí tồn dư, thay đổi đường nuôi dưỡng theo phác đồ và chỉ định, không tự quyết định từ ngưỡng 200 mL.

Kết thúc quy trình

- Đánh giá lại tình trạng người bệnh và kết quả kỹ thuật; bảo đảm tư thế an toàn, thu gom dụng cụ và vệ sinh tay.

- Ghi thời gian, nội dung thực hiện, thuốc/dịch và thông số thực tế nếu có, đáp ứng và bất thường; bàn giao người bệnh và kế hoạch theo dõi cho nhân viên hoặc bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

- Ống thông vào thanh quản và khí quản gây co thắt thanh môn, khó thở cấp.

- Chảy máu vùng mũi hầu họng do loét tì đè của ống thông dạ dày.

- Nôn trào ngược.

- Trào ngược do thể tích dịch tồn dư quá lớn, đưa vào dạ dày một thể tích quá lớn, do liệt dạ dày ruột chức năng.

- Tụt ống thông dạ dày hoặc bị cuộn trong miệng thực quản khi cho ăn gây trào ngược và sặc vào đường hô hấp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế (2014), Quyết định về việc hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành hồi sức cấp cứu và chống độc, Hà Nội.

2. Bộ Y tế (2023), Quyết định số 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (căn cứ cấu trúc và định dạng).

3. Trần Thị Thuận (2007), Điều dưỡng cơ bản II, trang 72 - 81.

4. NICE. CG32 Nutrition support for adults.
https://www.nice.org.uk/guidance/cg32/chapter/recommendations

Phụ lục

Danh mục chuẩn bị để thực hiện quy trình nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày

57

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng đã được đào tạo, có năng lực và được phân công thực hiện kỹ thuật	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Bơm tiêm 50 mL	Cái	01
3.2	băng keo	Cuộn	Theo nhu cầu cố định
3.3	Gạc vô trùng	Bọc	01
3.4	Găng tay sạch	Đôi	01
3.5	Cốc đựng thức ăn chia độ	Cái	01
3.6	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	Chai	01
3.7	Khăn sạch	Cái	01
3.8	Thức ăn cho người bệnh theo chỉ định.	mL	theo chỉ định
3.9	Hộp thuốc chống sốc	Hộp	01
3.10	Nước tráng ống phù hợp, thể tích theo chỉ định và giới hạn dịch	mL	Theo chỉ định
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Ống nghe	Bộ	01
4.2	Máy theo dõi nối với cáp điện tim, cáp SpO_2, cáp đo huyết áp	Máy	01

58

15. QUY TRÌNH ĐẶT ỐNG THÔNG DẪN LƯU BÀNG QUANG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: đặt ống thông dẫn lưu bàng quang là thủ thuật đưa một ống thông tiệt trùng qua niệu đạo vào bàng quang để dẫn lưu nước tiểu ra ngoài.

- Nguyên lý: ống thông được đưa vào niệu đạo đến bàng quang, sau đó cố định để đảm bảo dòng nước tiểu chảy liên tục ra ngoài, giúp theo dõi và điều trị.

- Mục đích:

+ Theo dõi lượng nước tiểu.

+ Điều trị bí tiểu, giữ bàng quang trống.

+ Chuẩn bị cho một số thủ thuật, phẫu thuật.

+ Dự phòng tổn thương do bí tiểu cấp/mạn.

2. CHỈ ĐỊNH

- Trường hợp người bệnh bí tiểu do nhiều nguyên nhân (bệnh lý liệt cơ vòng cổ bàng quang, do dùng thuốc an thần, giãn cơ..).

- Không đặt catheter lưu chỉ để xử trí tiểu không tự chủ hoặc thay thế chăm sóc vệ sinh; chỉ đặt khi có chỉ định cụ thể, được ghi nhận.

- Vết thương loét, nhiễm trùng nặng vùng hậu môn trực tràng, âm đạo.

- Trước và sau các phẫu thuật.

- Lấy mẫu nước tiểu bằng catheter chỉ khi có chỉ định và không thể lấy mẫu phù hợp bằng phương pháp ít xâm lấn hơn.

- Theo dõi số lượng nước tiểu trong các trường hợp sốc, suy thận cấp, người bệnh dùng an thần giãn cơ ….

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Chấn thương niệu đạo như dập, rách, đứt niệu đạo, nhiễm khuẩn niệu đạo mủ.

- Nghi tắc nghẽn đường niệu hoặc đặt khó: không cố đẩy ống, báo bác sĩ để lựa chọn phương pháp; tăng sinh tuyến tiền liệt không được xem là chống chỉ định tuyệt đối trong mọi trường hợp.

4. THẬN TRỌNG

- Đặt nhẹ nhàng, tránh tổn thương niệu đạo.

- Kiểm tra tình trạng dị ứng latex, thuốc sát khuẩn.

- Cẩn trọng với người bệnh nam lớn tuổi (tăng sinh tuyến tiền liệt).

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện: điều dưỡng.

5.2. Thuốc:

- Natri clorid 0,9%.

- Dung dịch sát khuẩn iode (Povidin) 10%.

59
- Gel bôi trơn vô khuẩn, tan trong nước, dùng một lần; thuốc tê tại chỗ nếu có chỉ định và đã kiểm tra dị ứng.

- Nước cất.

5.3. Vật tư

- Ống thông bàng quang kích cỡ phù hợp: 01 cái.

- Găng sạch: 01 đôi.

- Găng vô khuẩn.

- Khay quả đậu vô khuẩn.

- Bộ dụng cụ vô khuẩn.

- Khăn có lỗ: 01 cái.

- Gạc củ ấu vô khuẩn, gạc miếng vô khuẩn.

- Bơm tiêm 20 mL : 01 cái.

- Ống xét nghiệm (nếu cần).

- Bô dẹt.

- Tấm nilon 40 x 60 cm.

- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

5.4. Trang thiết bị

- Máy theo dõi nối với cáp điện tim, cáp SpO_2, cáp đo huyết áp.

- Bình phong.

5.5. Người bệnh

- Thông báo giải thích cho người bệnh và gia đình về mục đích của việc đặt ống thông bàng quang và yêu cầu sự hợp tác của gia đình người bệnh.

- Che bình phong.

- Người bệnh nằm ngửa, cởi quần, bộc lộ vùng lỗ niệu đạo, đắp ga.

- Trải nilon dưới mông, được vệ sinh bộ phận sinh dục.

5.6. Hồ sơ bệnh án: theo quy định của Bộ Y tế.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: ghi thời gian thực tế bằng giờ; định mức thời gian do bệnh viện xác nhận theo phương pháp và tình trạng người bệnh.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định.

- Xác nhận đúng người bệnh bằng ít nhất hai thông tin nhận diện, đúng chỉ định và vị trí; kiểm tra dị ứng và nguy cơ liên quan. Thực hiện bảng kiểm an toàn phù hợp, giải thích và đặt tư thế trước kỹ thuật.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: Kiểm tra dụng cụ, đưa tới giường bệnh

60
+ Điều dưỡng rửa tay bằng xà phòng tiệt khuẩn đúng quy trình kỹ thuật.

+ Điều dưỡng đội mũ, đeo khẩu trang.

+ Đưa dụng cụ đến giường để ở nơi thuận tiện.

+ Mở bộ dụng cụ, đổ dung dịch sát khuẩn iode 10% vào chén chun.

+ Tư thế và người bệnh đã được chuẩn bị sẵn, mở ga đắp để lộ bộ phận sinh dục.

- Bước 2: Sát khuẩn vệ sinh vùng sinh dục niệu đạo

+ Điều dưỡng sát khuẩn tay nhanh, đi găng sạch.

+ Dùng kìm kẹp gạc củ ấu sát khuẩn bộ phận sinh dục và lỗ tiểu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cho đến khi sạch bằng dung dịch Povidin 10%.

+ Điều dưỡng tháo bỏ găng sạch, sát khuẩn tay bằng dung dịch rửa tay nhanh.

- Bước 3: Đặt ống thông tiểu vô trùng

+ Đi găng vô khuẩn.

+ Trải khăn có lỗ.

+ Chuẩn bị dung dịch và thể tích bơm bóng đúng hướng dẫn của loại catheter; không mặc định 10 mL cho mọi sản phẩm.

+ Đặt khay quả đậu đã hấp tiệt khuẩn vào giữa 2 đùi người bệnh để đựng nước tiểu.

+ Nối ống thông tiểu với túi dẫn lưu.

+ Bôi gel bôi trơn vô khuẩn tan trong nước theo hướng dẫn sản phẩm.

+ Tay trái bộc lộ lỗ niệu đạo.

+ Sát trùng lại lỗ niệu đạo bằng Povidin 10%.

+ Tay phải cầm ống thông và nhẹ nhàng đưa ống thông qua niệu đạo vào bàng quang.

+ Đối với Người bệnh nam: tay phải cầm ống thông, tay trái nâng dương vật thẳng góc với thành bụng, đưa vào lỗ niệu đạo khoảng 10 cm, thấy vướng hạ dương vật xuống song song với thành bụng, tiếp tục đưa vào khoảng 10 - 15 cm thấy nước tiểu ra đẩy sâu thêm khoảng 3 - 5 cm.

+ Đối với Người bệnh nữ: tay trái bộc lộ lỗ niệu đạo, tay phải cầm ống thông đưa nhẹ nhàng vào niệu đạo 4 - 5 cm thấy nước tiểu ra đẩy thêm vào 3 - 5 cm.

+ Khi ống thông đã vào sâu trong bàng quang mới được bơm bóng chèn bằng nước cất theo thể tích ghi trên ống thông, kéo nhẹ ra đến khi thấy vướng.

+ Dùng gạc lau khô bộ phận sinh dục và đầu lỗ niệu đạo. Bỏ khăn lỗ.

+ Duy trì hệ thống dẫn lưu kín và mối nối sạch; không quấn gạc tẩm sát khuẩn quanh quy đầu thường quy. Đưa bao quy đầu về vị trí bình thường nếu đã kéo xuống.

+ Cố định catheter tránh lực kéo, đặt túi thấp hơn bàng quang, không chạm sàn; giữ dòng chảy không gập hoặc tắc. Thu dọn dụng cụ và vệ sinh tay.

61
+ Đặt người bệnh tư thế thích hợp, đắp ga, mặc lại quần áo cho người bệnh (nếu cần), ghi ngày đặt ống thông. Ghi hồ sơ bệnh án: diễn biến bệnh, thời gian, người thực hiện.

Kết thúc quy trình

- Đánh giá lại tình trạng người bệnh và kết quả kỹ thuật; bảo đảm tư thế an toàn, thu gom dụng cụ và vệ sinh tay.

- Ghi thời gian, nội dung thực hiện, thuốc/dịch và thông số thực tế nếu có, đáp ứng và bất thường; bàn giao người bệnh và kế hoạch theo dõi cho nhân viên hoặc bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

Chảy máu, chấn thương niệu đạo bàng quang: dừng thủ thuật, báo bác sĩ, đánh giá tổn thương, theo dõi các dấu hiệu sinh tồn và cầu bàng quang, tình trạng chảy máu.

7.2. Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

- Nhiễm khuẩn bệnh viện ngược dòng. Tắc ống thông do chảy máu và cục máu đông.

- Chấn thương, rách niệu đạo, tổn thương bàng quang. Đứt rách đầu bàng quang do người bệnh giật rách ống thông.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế (2023), Quyết định số 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (căn cứ cấu trúc và định dạng).

2. Trần Thị Thuận (2007), Điều dưỡng cơ bản II, trang 127 - 140.

3. CDC. Summary of Recommendations, Prevention of Catheter Associated Urinary Tract Infections. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/cauti/summary-of-recommendations.html

Phụ lục

Danh mục chuẩn bị để thực hiện quy trình đặt ống thông dẫn lưu bàng quang

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng đã được đào tạo, có năng lực và được phân công thực hiện kỹ thuật	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		
2.1	Natri clorid 0,9%	Chai	01
2.2	Dung dịch sát khuẩn iode (Povidin) 10%	Chai	01
2.3	Gel bôi trơn vô khuẩn tan trong nước	Tuýp	01

62

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Ống thông bàng quang kích cỡ phù hợp	Sợi	01
3.2	Bộ dụng cụ vô khuẩn	Bộ	01
3.3	Gạc củ ấu vô khuẩn, Gạc miếng vô khuẩn.	Bọc	01
3.4	Bơm tiêm 20 mL	Cái	01
3.5	Găng sạch, găng vô khuẩn	Đôi	01
3.6	Ống xét nghiệm (nếu cần)	Ống	01
3.7	Bô dẹt	Cái	01
3.8	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	Chai	01
3.9	Túi và dây dẫn lưu nước tiểu kín tương thích catheter	Bộ	01
3.10	Dung dịch bơm bóng đúng loại và thể tích ghi trên catheter	mL	Theo hướng dẫn sản phẩm
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Bình phong	Cái	01

63

16. QUY TRÌNH ĐẶT ỐNG THÔNG TIỂU 1 LẦN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: đặt ống thông tiểu một lần là kỹ thuật đưa ống thông tiệt trùng qua niệu đạo vào bàng quang để dẫn lưu nước tiểu ra ngoài rồi rút ra ngay sau khi dẫn lưu xong.

- Nguyên lý: ống thông được đưa vào niệu đạo đến bàng quang để lấy nước tiểu ra ngoài nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, hoặc làm sạch bàng quang.

- Mục đích:

+ Dẫn lưu nước tiểu tạm thời.

+ Lấy nước tiểu làm xét nghiệm.

+ Làm sạch bàng quang trước các thủ thuật.

+ Kiểm tra tồn lưu nước tiểu sau tiểu tiện.

2. CHỈ ĐỊNH

- Trường hợp người bệnh bí tiểu do nhiều nguyên nhân.

- Lấy nước tiểu làm xét nghiệm giúp chẩn đoán và điều trị.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chấn thương niệu đạo như dập, rách, đứt niệu đạo, nhiễm khuẩn niệu đạo mủ.

4. THẬN TRỌNG

- Thao tác nhẹ nhàng, tránh gây tổn thương niệu đạo.

- Sử dụng ống mềm, kích cỡ phù hợp.

- Cẩn trọng với người bệnh nam lớn tuổi (nguy cơ tổn thương tuyến tiền liệt).

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện: điều dưỡng.

5.2. Thuốc:

- Natri clorid 0,9%.

- Dung dịch sát khuẩn iode (Povidin) 10%.

- Gel bôi trơn vô khuẩn tan trong nước, dùng một lần.

5.3. Vật tư

- Ống thông thông tiểu cỡ phù hợp: 01 cái.

- Găng sạch.

- Găng vô khuẩn.

- Khay hạt đậu vô khuẩn.

- Bộ dụng cụ vô khuẩn.

- Khăn có lỗ.

- Gạc củ ấu vô khuẩn, gạc miếng vô khuẩn.

64

- Bơm tiêm 10 mL.

- Ống xét nghiệm (nếu cần).

- Bô dẹt.

- Tấm nilon 40 x 60 cm.

- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

5.4. Trang thiết bị: bình phong.

5.5. Người bệnh

- Thông báo giải thích cho người bệnh và gia đình về mục đích của việc đặt ống thông tiểu và yêu cầu sự hợp tác của gia đình người bệnh.

- Che bình phong.

- Người bệnh nằm ngửa, cởi quần, bộc lộ vùng lỗ niệu đạo, đắp ga.

- Trải nilon dưới mông, được vệ sinh bộ phận sinh dục.

5.6. Hồ sơ bệnh án: theo quy định của Bộ Y tế.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: dự kiến 0,08–0,17 giờ.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định.

- Xác nhận đúng người bệnh bằng ít nhất hai thông tin nhận diện, đúng chỉ định và vị trí; kiểm tra dị ứng và nguy cơ liên quan. Thực hiện bảng kiểm an toàn phù hợp, giải thích và đặt tư thế trước kỹ thuật.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: Kiểm tra dụng cụ, đưa tới giường bệnh

+ Điều dưỡng rửa tay bằng xà phòng tiệt khuẩn đúng quy trình kỹ thuật.

+ Điều dưỡng đội mũ, đeo khẩu trang.

+ Đưa dụng cụ đến giường để ở nơi thuận tiện.

+ Mở bộ dụng cụ, đổ dung dịch sát khuẩn PVP iode 10% vào chén chun.

+ Tư thế người bệnh đã được chuẩn bị sẵn, mở ga đắp để lộ bộ phận sinh dục.

- Bước 2: Sát khuẩn vệ sinh vùng sinh dục niệu đạo

+ Điều dưỡng sát khuẩn tay nhanh, đeo găng sạch.

+ Dùng kìm kẹp gạc củ ấu sát khuẩn bộ phận sinh dục và lỗ tiểu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cho đến khi sạch bằng dung dịch Povidin 10%.

+ Điều dưỡng tháo bỏ găng sạch, sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

- Bước 3: Đặt ống thông tiểu vô trùng

+ Đi găng vô khuẩn.

+ Trải khăn có lỗ.

65
+ Chuẩn bị ống thông tiểu ngắt quãng phù hợp; thông tiểu một lần không cần bơm bóng chèn.

+ Đặt khay quả đậu đã hấp tiệt khuẩn vào giữa 2 đùi người bệnh để đựng nước tiểu.

+ Bôi gel bôi trơn vô khuẩn tan trong nước theo hướng dẫn sản phẩm.

+ Tay trái bộc lộ lỗ niệu đạo.

+ Sát trùng lại lỗ niệu đạo bằng Povidin 10%.

+ Tay phải cầm ống thông và nhẹ nhàng đưa ống thông qua niệu đạo vào bàng quang.

+ Đối với Người bệnh nam: tay phải cầm ống thông, tay trái nâng dương vật thẳng góc với thành bụng, đưa vào lỗ niệu đạo khoảng 10 cm, thấy vướng hạ dương vật xuống song song với thành bụng, tiếp tục đưa vào khoảng 10 - 15 cm thấy nước tiểu ra đẩy sâu thêm khoảng 3 - 5 cm.

+ Đối với Người bệnh nữ: tay trái bộc lộ lỗ niệu đạo, tay phải cầm ống thông đưa nhẹ nhàng vào niệu đạo 4 - 5 cm thấy nước tiểu ra đẩy thêm vào 3 - 5 cm.

+ Khi có nước tiểu chảy, bảo đảm đầu ống ở trong bàng quang và dẫn lưu nhẹ nhàng. Không bơm bóng chèn trong thông tiểu một lần.

+ Khi dẫn lưu xong, rút ống nhẹ nhàng và thu gom đúng quy định; ghi lượng, tính chất nước tiểu và đáp ứng người bệnh.

+ Nếu lấy mẫu xét nghiệm, lấy vô khuẩn trực tiếp từ catheter theo quy trình lấy mẫu; không gọi mẫu qua catheter là mẫu nước tiểu giữa dòng.

+ Dùng gạc lau khô bộ phận sinh dục và đầu lỗ niệu đạo.

+ Bỏ khăn lỗ.

+ Thu dọn dụng cụ.

+ Đặt người bệnh tư thế thích hợp, đắp ga, mặc lại quần áo cho người bệnh.

+ Ghi phiếu chăm sóc.

Kết thúc quy trình

- Đánh giá lại tình trạng người bệnh và kết quả kỹ thuật; bảo đảm tư thế an toàn, thu gom dụng cụ và vệ sinh tay.

- Ghi thời gian, nội dung thực hiện, thuốc/dịch và thông số thực tế nếu có, đáp ứng và bất thường; bàn giao người bệnh và kế hoạch theo dõi cho nhân viên hoặc bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

Chảy máu, chấn thương niệu đạo bàng quang: dừng thủ thuật, báo bác sĩ, đánh giá tổn thương, theo dõi các dấu hiệu sinh tồn và cầu bàng quang, tình trạng chảy máu.

7.2. Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

- Nhiễm khuẩn bệnh viện ngược dòng. Tắc ống thông do chảy máu và cục máu đông.

66
- Chấn thương, rách niệu đạo, tổn thương bàng quang. Đứt rách đầu bàng quang do Người bệnh giật rách ống thông.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế (2023), Quyết định số 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (căn cứ cấu trúc và định dạng).

2. Trần Thị Thuận (2007), Điều dưỡng cơ bản II, trang 110 - 115.

3. CDC. Guideline for Prevention of Catheter Associated Urinary Tract Infections, 2009. https://www.cdc.gov/infection-control/media/pdfs/guideline-cauti-h.pdf

Phụ lục

Danh mục chuẩn bị để thực hiện quy trình kỹ thuật đặt ống thông tiểu 1 lần

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng đã được đào tạo, có năng lực và được phân công thực hiện kỹ thuật	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		
2.1	Gel bôi trơn vô khuẩn tan trong nước, dùng một lần	Theo chế phẩm	Theo hướng dẫn sản phẩm
2.2	Dung dịch sát khuẩn iode (Povidin) 10%	Chai	01
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Ống thông thông tiểu kích cỡ phù hợp	Sợi	01
3.2	Bộ dụng cụ vô khuẩn	Bộ	01
3.3	Gạc củ ấu vô khuẩn, Gạc miếng vô khuẩn.	Bọc	01
3.4	Găng sạch, găng vô khuẩn	Đôi	01
3.5	Ống xét nghiệm (nếu cần)	Ống	01
3.6	Bô dẹt	Cái	01
3.7	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	Chai	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Bình phong	Cái	01

67

17. QUY TRÌNH KHÍ DUNG THUỐC GIÃN PHẾ QUẢN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: khí dung thuốc giãn phế quản là kỹ thuật sử dụng máy khí dung để đưa thuốc giãn phế quản dạng hơi vào đường hô hấp, giúp làm giãn cơ trơn đường thở, giảm tắc nghẽn và cải thiện lưu thông khí phế quản.

- Nguyên lý: thuốc giãn phế quản được đưa vào dưới dạng khí dung nhỏ li ti, dễ dàng thẩm thấu vào đường thở và tác động trực tiếp lên cơ trơn của phế quản để làm giãn, cải thiện tình trạng thở khó.

- Mục đích:

+ Giảm tắc nghẽn đường thở, cải thiện lưu thông khí.

+ Điều trị các bệnh lý phổi như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

+ Cải thiện chức năng hô hấp và giảm triệu chứng khó thở.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có co thắt phế quản hoặc chỉ định dùng thuốc giãn phế quản cụ thể; tiền sử hen/COPD đơn thuần không thay thế đánh giá hiện tại.

- Cơn hen phế quản cấp.

- Co thắt phế quản do nhiễm khuẩn phổi.

- Không chỉ định thuốc giãn phế quản chỉ vì đờm đặc nếu không có co thắt phế quản hoặc chỉ định phù hợp.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định theo từng thuốc và chế phẩm, đặc biệt quá mẫn với thành phần. Bệnh tim mạch, loạn nhịp cần đánh giá thận trọng và theo dõi; không áp dụng một chống chỉ định chung cho tất cả thuốc khí dung.

4. THẬN TRỌNG

- Đảm bảo liều thuốc phù hợp với tình trạng của người bệnh.

- Theo dõi thường xuyên trong suốt quá trình sử dụng thuốc để phát hiện tác dụng phụ.

- Cẩn trọng khi sử dụng ở người bệnh có bệnh tim mạch hoặc tiểu đường.

- Tránh tiếp xúc thuốc với mắt.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện: điều dưỡng.

5.2. Thuốc: thuốc khí dung theo chỉ định của bác sĩ.

5.3. Vật tư

- Bộ dây khí dung dùng riêng cho từng người bệnh.

- Bơm tiêm 5 mL, kim rút thuốc.

- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

68

5.4. Trang thiết bị

Máy khí dung.

5.5. Người bệnh

Thông báo giải thích cho người bệnh hoặc gia đình người bệnh về kỹ thuật sắp làm.

5.6. Hồ sơ bệnh án: theo quy định của Bộ Y tế.

5.7. Thời gian: mỗi lần phun khí dung khoảng 0,33 giờ.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Thực hiện 5 đúng.

- Thực hiện bảng kiểm an toàn kỹ thuật.

- Xác nhận đúng người bệnh bằng ít nhất hai thông tin nhận diện, đúng chỉ định và vị trí; kiểm tra dị ứng và nguy cơ liên quan. Thực hiện bảng kiểm an toàn phù hợp, giải thích và đặt tư thế trước kỹ thuật.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: thông báo, động viên người bệnh hợp tác thực hiện kỹ thuật.

- Bước 2: điều dưỡng đội mũ, đeo khẩu trang. Mang dụng cụ, thuốc đến giường bệnh. Đặt người bệnh ở tư thế thích hợp.

- Bước 3: cắm điện và kiểm tra hoạt động của máy khí dung. Cắm bộ dây khí dung vào máy khí dung.

- Bước 4: sát khuẩn tay nhanh. Pha thuốc theo chỉ định. Bơm thuốc vào bình khí dung.

- Bước 5: bật máy khí dung khi máy hoạt động thấy hơi thuốc phun ra.

- Bước 6: đeo mặt nạ khí dung cho người bệnh.

- Bước 7: theo dõi đáp ứng; nếu khó thở tăng, co thắt phế quản nghịch thường, đau ngực hoặc loạn nhịp, ngừng khí dung và báo bác sĩ để xử trí.

- Bước 8: hết thuốc, tắt máy khí dung, lấy mặt nạ khỏi người bệnh.

- Bước 9: thu dọn dụng cụ, vệ sinh máy khí dung, để đúng nơi quy định.

- Bước 10: rửa tay. Ghi phiếu chăm sóc.

Kết thúc quy trình

- Đánh giá lại tình trạng người bệnh và kết quả kỹ thuật; bảo đảm tư thế an toàn, thu gom dụng cụ và vệ sinh tay.

- Ghi thời gian, nội dung thực hiện, thuốc/dịch và thông số thực tế nếu có, đáp ứng và bất thường; bàn giao người bệnh và kế hoạch theo dõi cho nhân viên hoặc bộ phận tiếp theo khi cần.

69

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

- Mạch, khó thở, SpO_2, huyết áp, đờm trong khí phế quản, phát hiện các tai biến và biến chứng.

- Khó thở, suy hô hấp cấp.

- Sặc vào đường hô hấp.

- Trào ngược từ đường tiêu hóa vào đường thở.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế (2014), Quyết định về việc hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành hồi sức cấp cứu và chống độc, Hà Nội.

2. Bộ Y tế (2023), Quyết định số 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (căn cứ cấu trúc và định dạng).

Phụ lục

Danh mục chuẩn bị để thực hiện quy trình khí dung giãn phế quản

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng đã được đào tạo, có năng lực và được phân công thực hiện kỹ thuật	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		
2.1	Thuốc khí dung theo chỉ định của bác sĩ	Ống hoặc lọ	Tùy số lượng sử dụng
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Bộ dây khí dung dùng riêng cho từng người	Bộ	01
3.2	Bơm tiêm 5 mL, kim rút thuốc	Cái	01
3.3	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	Chai	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Máy khí dung	Cái	01

70

18. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH

1. ĐẠI CƯƠNG

Trạng thái động kinh là tình trạng co giật kéo dài trên 5 phút hoặc tái phát nhiều cơn mà người bệnh không phục hồi ý thức giữa các cơn. Đây là một cấp cứu thần kinh cần xử trí kịp thời để tránh tổn thương não và tử vong.

- Nguyên lý: Ngăn chặn các cơn động kinh kéo dài bằng cách duy trì sự ức chế thần kinh thông qua các thuốc an thần, chống co giật kịp thời và hỗ trợ chức năng sống.

- Mục đích:

+ Ngăn ngừa tổn thương não không hồi phục.

+ Duy trì chức năng hô hấp, tuần hoàn.

+ Ổn định tình trạng thần kinh cho người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có dấu hiệu trạng thái động kinh: co giật liên tục trên 5 phút hoặc nhiều cơn liên tiếp không phục hồi ý thức.

- Động kinh kèm suy hô hấp, rối loạn huyết động.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không có chống chỉ định tuyệt đối.

- Thận trọng ở người bệnh dị ứng với thuốc chống co giật.

4. THẬN TRỌNG

- Cẩn thận với liều lượng thuốc an thần ở người bệnh suy gan, suy thận.

- Theo dõi sát chức năng hô hấp khi dùng thuốc an thần mạnh.

- Đề phòng tụt huyết áp sau khi tiêm thuốc.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ cấp cứu.

- Điều dưỡng viên.

b) Nhân lực hỗ trợ:

- Kỹ thuật viên xét nghiệm (nếu cần).

- Nhân viên hỗ trợ hồi sức.

5.2. Thuốc

- Benzodiazepine và thuốc chống động kinh theo phác đồ cấp cứu được bác sĩ chỉ định; chuẩn bị đúng tên, nồng độ, liều, đường dùng và tốc độ.

- Midazolam: đường dùng theo chế phẩm và phác đồ; không tự chuyển dạng tiêm sang nhỏ mũi.

71
- Lorazepam (tiêm tĩnh mạch nếu có).

- Thuốc hỗ trợ: Phenytoin, Levetiracetam, Phenobarbital.

5.3. Vật tư

- Ống tiêm, kim tiêm vô trùng.

- Dây truyền dịch.

- Bình oxy, mặt nạ oxy.

- Ống nội khí quản, dụng cụ đặt nội khí quản.

5.4. Trang thiết bị

- Máy hút đờm.

- Monitor theo dõi huyết áp, SpO_2, nhịp tim.

- Máy thở (nếu cần hỗ trợ hô hấp).

5.5. Người bệnh

- Đặt người bệnh nằm tư thế an toàn, nghiêng đầu sang một bên để tránh hít sặc.

- Tháo bỏ các vật dụng nguy hiểm khỏi người bệnh.

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Phiếu chăm sóc điều dưỡng.

- Các chỉ định thuốc từ bác sĩ.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: ước tính: 1 - 2 giờ hoặc cho đến khi kiểm soát được cơn động kinh.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: nơi có phương tiện cấp cứu; kích hoạt hỗ trợ và chuyển khu hồi sức phù hợp khi cần.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

- Kiểm tra chỉ định của bác sĩ.

- Xác định loại thuốc, liều lượng, đường dùng phù hợp.

- Xác nhận đúng người bệnh bằng ít nhất hai thông tin nhận diện, đúng chỉ định và vị trí; kiểm tra dị ứng và nguy cơ liên quan. Thực hiện bảng kiểm an toàn phù hợp, giải thích và đặt tư thế trước kỹ thuật.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: gọi hỗ trợ cấp cứu, ghi thời điểm bắt đầu cơn; đánh giá ý thức, hô hấp và tuần hoàn.

+ Kiểm tra ý thức, hô hấp, tuần hoàn.

+ Xác định có trạng thái động kinh hay không.

- Bước 2: đảm bảo đường thở.

+ Đặt người bệnh nằm nghiêng, hút đờm dãi nếu cần.

72
+ Hỗ trợ thông khí khi cần; bác sĩ hoặc người có thẩm quyền kiểm soát đường thở nếu không bảo vệ được đường thở, suy hô hấp hoặc cần điều trị nâng cao.

- Bước 3: thực hiện điều trị ban đầu.

+ Dùng benzodiazepine theo y lệnh/phác đồ đã phê duyệt, phù hợp tuổi, cân nặng và đường dùng; kiểm tra liều đã được sử dụng trước đó. Không áp dụng liều diazepam 10 mg hoặc midazolam 5 mg cố định cho mọi người bệnh.

+ Nếu cơn không dừng sau liều đầu, báo bác sĩ và thực hiện liều tiếp theo theo phác đồ; sau hai liều benzodiazepine không đáp ứng, điều trị hàng hai theo chỉ định và theo dõi hồi sức. Không tự nhắc liều không giới hạn.

- Bước 4: hỗ trợ chức năng sống.

+ Oxy theo tình trạng hô hấp và mục tiêu SpO_2; không mặc định một lưu lượng cho mọi loại mặt nạ. Chuẩn bị bóng–mặt nạ, hút và phương tiện hồi sức.

+ Đặt đường truyền tĩnh mạch, bù dịch nếu cần.

+ Theo dõi liên tục mạch, huyết áp, SpO_2.

- Bước 5: xử trí nâng cao (nếu cần)

+ Kiểm tra ngay đường huyết mao mạch, xử trí bất thường theo phác đồ; lấy xét nghiệm điện giải, khí máu và các xét nghiệm khác theo chỉ định, không làm chậm điều trị cơn.

+ Chuyển người bệnh vào khoa Hồi sức tích cực nếu không kiểm soát được.

- Bước 6: kết thúc quy trình, đánh giá lại tình trạng người bệnh sau khi ngừng cơn động kinh.

- Ghi hồ sơ: ghi đầy đủ thời gian, liều lượng thuốc đã sử dụng, diễn tiến tình trạng sau can thiệp và các can thiệp đã thực hiện.

Kết thúc quy trình

- Đánh giá lại tình trạng người bệnh và kết quả kỹ thuật; bảo đảm tư thế an toàn, thu gom dụng cụ và vệ sinh tay.

- Ghi thời gian, nội dung thực hiện, thuốc/dịch và thông số thực tế nếu có, đáp ứng và bất thường; bàn giao người bệnh và kế hoạch theo dõi cho nhân viên hoặc bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

- Ngưng thở do thuốc an thần.

- Tụt huyết áp.

7.2. Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

- Hồi sức tim phổi nếu ngưng tim, ngừng thở.

- Kiểm soát suy hô hấp muộn.

73

7.3. Biến chứng muộn

- Tổn thương não do thiếu oxy.
- Viêm phổi hít.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế (2014), Quyết định về việc hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành hồi sức cấp cứu và chống độc, Hà Nội.

2. 2 .Bộ Y tế (2020), Quyết định về việc ban hành tài liệu hướng dẫn chẩn đoán điều trị rối loạn tâm thần thường gặp, Hà Nội.

3. Bộ Y tế (2023), Quyết định số 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (căn cứ cấu trúc và định dạng).

4. NICE. NG217, section 7, Treating status epilepticus. https://www.nice.org.uk/guidance/ng217/chapter/7-Treating-status-epilepticus-repeated-or-cluster-seizures-and-prolonged-seizures

Phụ lục

Danh mục chuẩn bị để thực hiện quy trình kiểm soát trạng thái động kinh

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Bác sĩ	Người	01
1.2	Điều dưỡng được đào tạo cấp cứu, có năng lực và được phân công thực hiện	Người	Theo tổ chức cấp cứu
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		
2.1	Diazepam 10 mg/2 mL	Ống	Tùy số lượng sử dụng
2.2	Midazolam 5 mg/5 mL	Ống	Tùy số lượng sử dụng
2.3	Phenytoin 250 mg/5 mL	Ống	Tùy số lượng sử dụng
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Bơm tiêm 5 mL	Cái	Tùy số lượng sử dụng
3.2	Dây truyền dịch	Sợi	01
3.3	Mặt nạ oxy	Cái	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Máy hút đờm.	Máy	01

74

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
4.2	Monitor theo dõi huyết áp, SpO_2, nhịp tim.	Máy	01
4.3	Máy thở (nếu cần hỗ trợ hô hấp).	Máy	01

75

19. QUY TRÌNH GIẢM ĐAU BẰNG MORPHIN TĨNH MẠCH THEO KIỂU PCA

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: PCA (Patient Controlled Analgesia) là phương pháp giảm đau qua đường tĩnh mạch cho phép người bệnh tự điều khiển liều thuốc giảm đau (morphin) bằng cách nhấn nút bơm điện tử, giúp kiểm soát đau chủ động.

- Nguyên lý: Thiết bị bơm PCA được cài đặt sẵn các thông số (liều bolus, thời gian khóa, liều tối đa trong 4 giờ…), người bệnh chủ động dùng thuốc giảm đau trong giới hạn an toàn.

- Mục đích:

+ Kiểm soát đau hiệu quả sau phẫu thuật hoặc trong điều trị đau cấp tính, mạn tính.

+ Giảm liều dùng morphin tổng thể.

+ Tăng sự hài lòng và chủ động của người bệnh trong kiểm soát đau.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đau sau mổ.

- Đau do ung thư cần sử dụng opioid.

- Đau cấp nặng không đáp ứng với giảm đau thông thường.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh không hiểu được cách sử dụng bơm PCA.

- Mất tri giác hoặc rối loạn ý thức.

- Suy hô hấp nặng.

- Dị ứng với morphin hoặc opioid.

- Trẻ nhỏ không hợp tác.

4. THẬN TRỌNG

- Người già, người suy thận, suy gan.

- Người bệnh có tiền sử ngưng thở khi ngủ.

- Dùng đồng thời thuốc an thần, ức chế hô hấp.

- Theo dõi sát dấu hiệu suy hô hấp, an thần quá mức.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

- Bác sĩ chuyên khoa chỉ định.

- Điều dưỡng được đào tạo PCA.

5.2. Thuốc

Morphin sulfat 10 mg/mL hoặc dạng phù hợp theo chỉ định.

76

5.3. Vật tư

- Dây truyền tĩnh mạch.

- Bơm PCA.

- Bơm tiêm.

- Găng tay.

- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

- băng keo.

5.4. Trang thiết bị

- Máy theo dõi nối với cáp điện tim, cáp SpO_2, cáp huyết áp.

5.5. Người bệnh

- Được giải thích rõ ràng về mục đích, cách sử dụng nút PCA, các dấu hiệu cần báo nhân viên y tế.

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Chỉ định bác sĩ.

- Phiếu theo dõi giảm đau PCA.

- Cam kết sử dụng PCA nếu có.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

- Thời gian thiết lập ban đầu: 30 - 60 phút.

- Theo dõi duy trì: liên tục trong suốt thời gian sử dụng PCA.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng bệnh, phòng hậu phẫu, khoa hồi sức, nơi có nhân viên y tế theo dõi 24/24 giờ.

5.9. Kiểm tra hồ sơ

Kiểm tra chỉ định bác sĩ, phiếu cam kết, phiếu đánh giá đau ban đầu, thông số cài đặt bơm.

- Xác nhận đúng người bệnh bằng ít nhất hai thông tin nhận diện, đúng chỉ định và vị trí; kiểm tra dị ứng và nguy cơ liên quan. Thực hiện bảng kiểm an toàn phù hợp, giải thích và đặt tư thế trước kỹ thuật.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Các bước thực hiện

- Bước 1: chuẩn bị đầy đủ thuốc, thiết bị và giải thích kỹ cho người bệnh.

- Bước 2: rửa tay, mang găng tay sạch.

- Bước 3: cài đặt bơm PCA theo chỉ định (liều bolus, thời gian khóa, liều tối đa).

- Bước 4: nối dây truyền PCA vào đường truyền tĩnh mạch của người bệnh.

- Bước 5: kiểm tra độc lập thuốc, nồng độ và thông số bơm theo quy định thuốc nguy cơ cao; hướng dẫn chỉ người bệnh tự nhấn nút PCA. Người nhà và nhân viên không nhấn thay để tăng liều.

77
- Bước 6: theo dõi sát các chỉ số sinh hiệu, dấu hiệu ngộ độc morphin (ức chế hô hấp, an thần...).

- Bước 7: ghi nhận lượng morphin sử dụng, cơn đau và tác dụng phụ.

- Bước 8: kết thúc PCA theo chỉ định bác sĩ, tháo bỏ thiết bị, đánh giá kết quả giảm đau.

6.2. Ghi hồ sơ

- Ghi nhận đầy đủ thời gian bắt đầu và kết thúc sử dụng PCA.

- Liều lượng morphin sử dụng.

- Đánh giá hiệu quả giảm đau và các phản ứng phụ.

- Ghi vào phiếu theo dõi chuyên biệt hoặc bệnh án.

Kết thúc quy trình

- Đánh giá lại tình trạng người bệnh và kết quả kỹ thuật; bảo đảm tư thế an toàn, thu gom dụng cụ và vệ sinh tay.

- Ghi thời gian, nội dung thực hiện, thuốc/dịch và thông số thực tế nếu có, đáp ứng và bất thường; bàn giao người bệnh và kế hoạch theo dõi cho nhân viên hoặc bộ phận tiếp theo khi cần.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Tai biến trong khi thực hiện

- An thần quá mức.

- Ức chế hô hấp.

- Tụt huyết áp.

- Xử trí:

+ Ngừng PCA, gọi hỗ trợ, đánh giá ý thức, nhịp thở, SpO_2 và tuần hoàn; bảo đảm đường thở, hỗ trợ thông khí khi cần.

+ Hồi sức tích cực.

+ Dùng Naloxon theo chỉ định bác sĩ.

7.2. Tai biến sau thực hiện

- Buồn nôn, nôn.

- Táo bón.

- Ngứa, bí tiểu.

- Xử trí: dùng thuốc điều trị triệu chứng theo chỉ định.

7.3. Biến chứng muộn

- Lệ thuộc thuốc giảm đau (hiếm gặp).

- Gây ra tình trạng tăng cảm giác đau.

78

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế (2023), Quyết định số 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (căn cứ cấu trúc và định dạng).

2. Bệnh viện Bạch Mai (2022), Quyết định về việc ban hành tài liệu đào tạo quản lý đau, Hà Nội.

Phụ lục danh mục chuẩn bị để thực hiện

quy trình giảm đau bằng morphin tĩnh mạch theo kiểu PCA

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Bác sĩ được đào tạo chuyên khoa	Người	01
1.2	Điều dưỡng được đào tạo PCA được thực hiện	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		
2.1	Morphin sulfat 10 mg/mL	ống	Theo chỉ định
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Dây truyền	Bộ	01
3.2	Bơm tiêm	Cái	01
3.3	băng keo	Cuộn	01
3.4	Găng tay sạch	Đôi	01
3.5	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	Chai	01
3.6	Hộp thuốc chống sốc	Hộp	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Máy theo dõi nối với cáp điện tim, cáp SpO_2, cáp đo huyết áp	Máy	01
4.2	Bơm PCA theo hướng dẫn thiết bị, có chức năng khóa thông số	Cái	01

79

PHỤ LỤC RÀ SOÁT VÀ XÁC NHẬN TRƯỚC BAN HÀNH

Các mục dưới đây phục vụ hội đồng thẩm định xác nhận trước khi ban hành. Chưa có quyết định nội bộ, hướng dẫn thuốc/thiết bị cụ thể hoặc tài liệu gốc đầy đủ để xác nhận các thông số tại bệnh viện.

Nhóm nội dung	Nội dung cần xác nhận	Kết quả / Người duyệt
Toàn bộ 19 quy trình	Xác nhận tên kỹ thuật và phạm vi danh mục được phê duyệt; ký danh sách hội đồng, ban biên soạn; bổ sung quyết định ban hành, mã tài liệu, phiên bản và ngày áp dụng.	
Thuốc và vật tư trong phụ lục	Đối chiếu từng bảng với mục 5: tên hoạt chất, nồng độ/hàm lượng, dạng/đường dùng, đơn vị và số lượng. Dung dịch sát khuẩn, cỡ ống/kim và vật tư cần theo danh mục thực tế; không suy đoán số lượng còn trống.	
QT 1 đến 5	Duyệt thuốc, đường dùng, vị trí tiêm, cỡ kim, giới hạn thể tích và tốc độ theo chế phẩm và nhóm tuổi; dùng quy trình phản vệ hiện hành và quy trình thử phản ứng chuyên biệt.	
QT 6	Xác nhận chỉ định và cách đọc nghiệm pháp dây thắt theo hướng dẫn sốt xuất huyết đang áp dụng; kiểm tra lại tiêu chí tuổi dưới 3 trong bản nguồn.	
QT 7	Xác nhận chỉ định vỗ rung, dẫn lưu tư thế và hút đờm theo từng bệnh; natri clorid không dùng mặc định nếu kỹ thuật không có chỉ định thuốc.	
QT 8	Xác nhận tuyến phối hợp tâm thần, tâm lý, đánh giá nguy cơ tự hại và quy trình báo cáo theo pháp luật; không đưa chi phí quản lý vào nguồn lực trực tiếp.	
QT 9	Lấy mẫu tỵ hầu là khâu thu thập bệnh phẩm; quy trình xét nghiệm thuộc hướng dẫn riêng. Xác nhận chỉ định sàng lọc, loại que, môi trường vận chuyển, thời gian và nhiệt độ theo xét nghiệm thực tế.	
QT 10 đến 12	Xác nhận dung dịch sát khuẩn, loại băng, lịch thay và chỉ định duy trì/rút catheter; riêng trẻ dưới 2 tháng cần hướng dẫn phù hợp. Đối chiếu phụ lục với quy trình đã chỉnh.	

80

Nhóm nội dung	Nội dung cần xác nhận	Kết quả / Người duyệt
QT 13 và 14	Phê duyệt phương pháp xác nhận vị trí ống trước sử dụng, người đọc X-quang, loại giấy pH; ban hành kế hoạch dinh dưỡng, tư thế, nước tráng ống và theo dõi dung nạp cá thể hóa.	
QT 15 và 16	Tách rõ thông tiểu lưu và một lần; duyệt gel, ống, thể tích bóng theo sản phẩm và hệ thống dẫn lưu kín; không bơm bóng trong thông tiểu một lần.	
QT 17	Duyệt thuốc, liều và dung môi, loại máy và thời gian khí dung theo thiết bị; bổ sung xử trí từng tác dụng không mong muốn theo chế phẩm.	
QT 18	Phê duyệt phác đồ động kinh theo tuổi/cân nặng; liều, đường dùng, tốc độ và giới hạn nhắc liều cần bác sĩ quyết định. Không dùng liều cố định không phân nhóm.	
QT 19	Phê duyệt bộ thông số PCA, mẫu y lệnh, kiểm tra độc lập và tần suất theo dõi đau/an thần/hô hấp; chỉ người bệnh nhấn nút. Kiểm tra tài liệu Bạch Mai 2022 còn thiếu số hiệu trong bản nguồn.	
Tài liệu tham khảo nguồn	Các tham khảo chỉ ghi Bộ Y tế 2012/2014/2020 và Bạch Mai 2022 chưa đủ số hiệu hoặc bản gốc: hội đồng kiểm tra trước trích dẫn chính thức. Các sách đã nêu được giữ để truy xuất, chưa được xác minh toàn văn.	